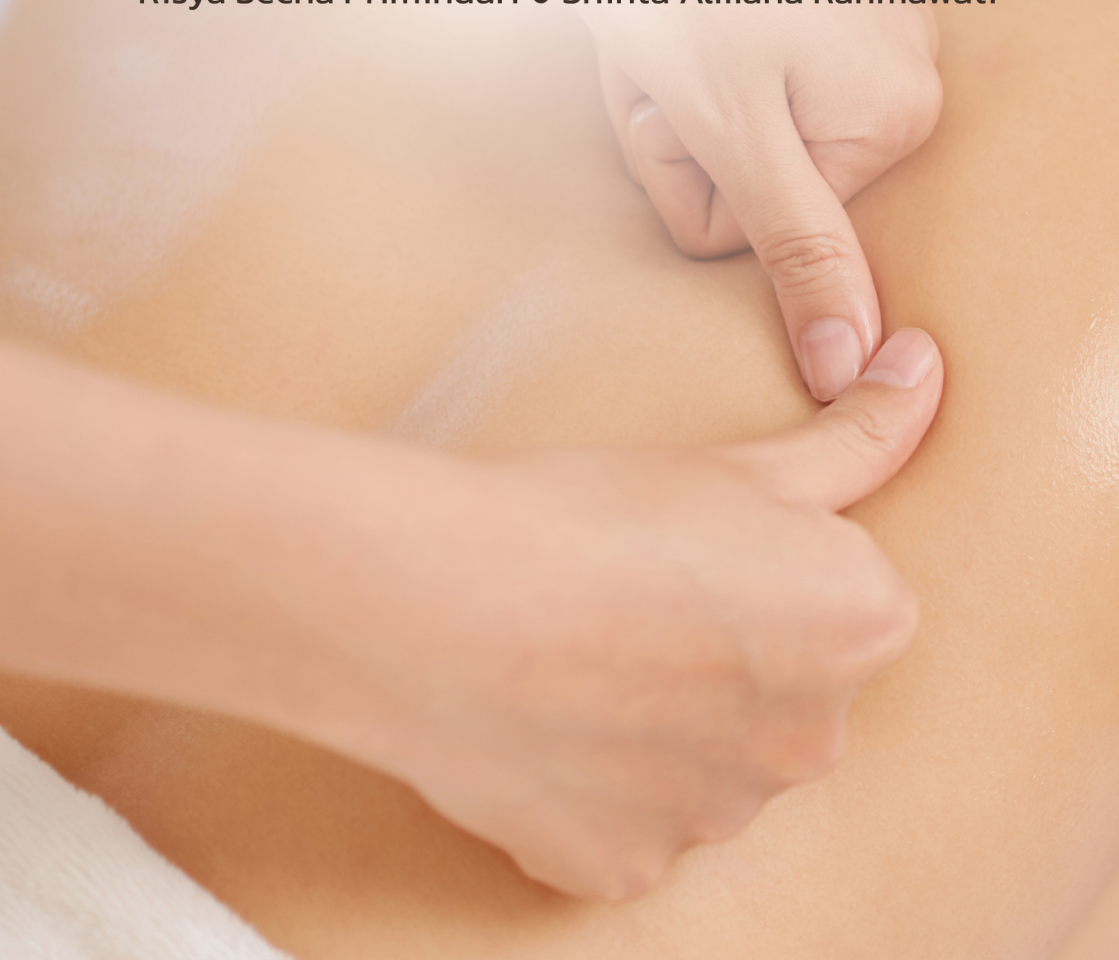




Nuansa
Fajar
Cemerlang

ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN INTERVENSI DEEP BACK MASSAGE MENGUNAKAN FRANGIPANI ESSENSIAL OIL TERHADAP PENURUNAN NYERI PERSALINAN KALA 1 FASE AKTIF

Amrina Nur Rohmah • Dwi Dianita Irawan
Risya Secha Primindari • Shinta Alifiana Rahmawati



**ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN:
INTERVENSI *DEEP BACK MASSAGE*
MENGUNAKAN *FRANGIPANI*
ESSENSIAL OIL TERHADAP PENURUNAN
NYERI PERSALINAN KALA 1 FASE AKTIF**

Penulis:

Amrina Nur Rohmah, S.Tr.Keb., M.Keb.

Dwi Dianita Irawan, S.Keb., Bd., M.Keb.

Risya Secha Primindari, S.Keb., Bd., M.Kes.

Bdn. Shinta Alifiana Rahmawati., S.ST., M.Keb.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Asuhan Kebidanan Persalinan: Intervensi *Back Massage* Menggunakan *Frangipani Essensial Oil* Terhadap Penurunan Nyeri Persalinan Kala 1 Fase Aktif

Penulis: Amrina Nur Rohmah, S.Tr.Keb., M.Keb
Dwi Dianita Irawan, S.Keb., Bd., M.Keb
Risya Secha Primindari, S.Keb., Bd., M.Kes
Bdn. Shinta Alifiana Rahmawati., S.ST., M.Keb

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantiso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7139-18-4

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Asuhan kebidanan persalinan : intervensi back massage
menggunakan frangipani essensial oil terhadap penurunan nyeri persalinan
kala 1 fase aktif / penulis, Amrina Nur Rohmah, S.Tr.Keb., M.Keb, Dwi
Dianita Irawan, S.Keb., Bd., M.Keb, Risya Secha Primindari, S.Keb., Bd.,
M.Kes, Bdn. Shinta Alifiana Rahmawati., S.ST., M.Keb

EDISI
PUBLIKASI
DESKRIPSI FISIK
IDENTIFIKASI
SUBJEK
KLASIFIKASI
PERPUSNAS ID

Cetakan pertama, Februari 2025
Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025.

viii, 101 halaman ; 30 cm
ISBN 978-634-7139-18-4

Persalinan
618.4 [23]

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1180677>

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku monograf yang berjudul **“Asuhan Kebidanan Persalinan: Intervensi Back Massage Menggunakan Frangipani Essential Oil Terhadap Penurunan Nyeri Persalinan Kala 1 Fase Aktif”** ini dapat terselesaikan. Buku ini merupakan hasil dari kajian dan penelitian yang bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah di bidang kebidanan, khususnya dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan pada ibu bersalin.

Nyeri persalinan kala 1 fase aktif merupakan tantangan yang dihadapi oleh ibu saat menjalani proses persalinan. Berbagai metode intervensi non-farmakologis telah dikembangkan untuk membantu mengurangi intensitas nyeri dan meningkatkan relaksasi, salah satunya melalui *back massage* dengan menggunakan *essential oil*. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan minyak *frangipani* sebagai alternatif yang diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi nyeri persalinan, serta memberikan ketenangan dan relaksasi yang diperlukan oleh ibu selama persalinan.

Dalam buku ini, disajikan pembahasan mengenai efektivitas *back massage* dengan *frangipani essential oil*, serta langkah-langkah penerapannya. Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi para tenaga kesehatan, khususnya bidan dan mahasiswa kebidanan, dalam memahami dan mengaplikasikan teknik ini secara tepat dan aman pada ibu bersalin.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penyelesaian buku ini, baik dari Universitas Muhammadiyah Lamongan maupun pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu kebidanan dan membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Lamongan, November 2024

Amrina Nur Rohmah, S.Tr.Keb., M.Keb.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

BAB 2 TINJUAN UMUM PERSALINAN 7

A. Definisi Persalinan	7
B. Fisiologi Persalinan.....	7
C. Penyebab Terjadinya Persalinan	12
D. Tanda-Tanda Persalinan.....	14
E. Faktor yang Mempengaruhi Persalinan	16
F. Tahapan Persalinan	19
G. Asuhan Sayang Ibu pada Masa Persalinan	23

BAB 3 NYERI PERSALINAN 27

A. Definisi Nyeri Persalinan	27
B. Faktor yang Mempengaruhi Nyeri Persalinan	28
C. Mekanisme Terjadinya Nyeri Persalinan	30
D. Dampak Nyeri Persalinan.....	32
E. Skala Pengukuran Nyeri Persalinan	34
F. Strategi Manajemen Nyeri Persalinan.....	36

G. Gate Control Theory.....	38
BAB 4 DEEP BACK MASSAGE.....	41
A. Definisi <i>Deep Back Massage</i>	41
B. Anatomi Punggung dalam Terapi <i>Massage</i>	42
C. Manfaat <i>Deep Back Massage</i> pada Persalinan....	46
D. Teknik Dasar <i>Deep Back Massage</i>	48
E. Posis Ibu Bersalin saat melakukan <i>Deep Back Massage</i>	54
F. Langkah-langkah pelaksanaan <i>Deep Back Massage</i> pada Persalinan	56
G. Kontraindikasi <i>Deep Back Massage</i> pada Persalinan.....	62
 BAB 5 FRANGIPANGI ESSENTIAL OIL.....	 67
A. Definisi dan Sumber <i>Frangipangi Essential Oil</i>	67
B. Komposisi <i>Frangipangi Essential Oil</i>	68
C. Manfaat <i>Frangipangi Essential Oil</i> dalam Manajemen Nyeri Persalinan.....	70
D. Keamanan dan Kontraindikasi penggunaan <i>Frangipangi Essential Oil</i>	73
E. Langkah-Langkah Penggunaan <i>Frangipangi Essential Oil</i> Dalam Manajemen Nyeri Persalinan	75

F. Mekanisme/Cara Kerja <i>Essential Oil</i> dalam Aromaterapi.....	77
G. Manfaat <i>Frangipangi Essential Oil</i> dalam Terapi Relaksasi	79

BAB 6 PENUTUP.....	83
---------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA.....	85
----------------------------	-----------

GLOSARIUM	95
------------------------	-----------

PROFIL PENULIS	97
-----------------------------	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO) mendefinisikan Angka Kematian ibu sebagai jumlah kematian wanita selama hamil sampai 42 hari setelah melahirkan. Kematian ini tidak disebabkan oleh kecelakaan atau cedera tetapi disebabkan oleh kehamilan itu sendiri dan penanganannya. Sementara itu terdapat 350 perempuan meninggal akibat komplikasi saat hamil dan persalinan. Resiko seorang wanita di negara berkembang meninggal lebih tinggi 33 kali dibanding wanita di negara maju. Menurut Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi yaitu 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Factor utama kematian ibu disebabkan oleh banyak kasus-kasus yang sebagian besar terjadi karena adanya perdarahan postpartum. Terjadinya durasi persalinan yang lama dan memanjang serta melemahnya kontraksi pada rahim dapat menyebabkan perdarahan postpartum. Lamanya proses persalinan berhubungan dengan kontraksi otot rahim, yang menyebabkan durasi persalinan menjadi lebih lama jika kontraksi tidak memadai.

Persalinan adalah suatu mekanisme fisiologis pada perempuan berupa pengeluaran hasil konsepsi dari dalam rahim melalui jalan lahir. Proses persalinan normal terjadi pada usia kehamilan *at term*, dimana janin telah siap dan matang atau

viable untuk dilahirkan. Hormon progesteron yang sebelumnya berperan untuk merilekskan otot polos Rahim, menjaga janin di Rahim dan menghambat kontraksi akan mengalami penurunan di akhir kehamilan. Sedangkan, hormone estrogen dan hormon oksitosin akan meningkat sehingga menyebabkan timbulnya kontraksi. Adanya kontraksi ini akan menimbulkan nyeri pada bawah uterus yang menjalar ke bagian punggung belakang. Proses terjadinya persalinan akan dimulai dengan adanya kontraksi pada rahim sehingga menyebabkan terjadinya dilatasi dan penipisan serviks dan terjadinya iskemia pada rahim, sehingga menimbulkan respon nyeri persalinan. Nyeri pada persalinan akan mulai dirasakan pada kala 1 fase laten, dimana dimulainya proses pembukaan serviks sampai 3 cm dari total 10 cm. Nyeri persalinan pada kala 1 fase laten memiliki sifat visceral (nyeri berasal dari bawah uterus lalu menyebar ke punggung belakang).

Nyeri yang berlebihan akan menimbulkan kecemasan pada ibu sehingga memicu produksi hormone prostaglandin dan timbul stress serta mempengaruhi kemampuan tubuh menahan rasa nyeri. Stress, kecemasan, dan ketakutan merupakan faktor psikologis yang berperan penting dalam mempengaruhi intensitas nyeri yang dialami ibu ketika persalinan.

Rasa sakit saat melahirkan adalah salah satu factor paling menakutkan yang dihadapi ibu hamil, sehingga banyak dari mereka akan memilih operasi Caesar untuk menghindari nyeri pada persalinan spontan. Rasa nyeri saat persalinan akan semakin intens dan mampu mengaktifkan saraf simpatis,

menyebabkan tekanan darah dan denyut nadi meningkat, peningkatan denyut jantung janin, uterus kontraksinya tidak terkoordinasi, hiperventilasi sehingga meningkatkan kebutuhan oksigen. Kondisi tersebut akan merangsang peningkatan katekolamin yang dapat menghambat kontraksi uterus, sehingga menyebabkan inersia uteri, partus lama, hipoksia janin. Meskipun nyeri persalinan merupakan proses yang normal, tetapi nyeri persalinan dianggap sebagai factor yang paling dihindari dalam suatu pengalaman persalinan. Nyeri pada persalinan akan menyebabkan ketidaknyamanan dan mampu mempengaruhi proses persalinan sehingga dibutuhkan suatu penanganan nyeri saat persalinan.

Setiap wanita memiliki beragam lingkungan, budaya, latar belakang, stamina dan kesehatan tubuh hal tersebut memberikan toleransi rasa sakit yang berbeda pada setiap wanita. Nyeri pada persalinan memerlukan penanganan yang baik dan tidak menimbulkan komplikasi agar nantinya tidak mengganggu persalinan. Berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan nyeri persalinan, baik secara farmakologis maupun nonfarmakologis. Terapi farmakologis yang sering dilakukan seperti pemberian analgesic epidural dirasa lebih mahal dan berpotensi menimbulkan efek yang kurang baik. Sehingga banyak terapi nonfarmakologi yang muncull dapat digunakan untuk mengurangi nyeri persalinan yang lebih murah, praktis, efektif, dan tanpa efek samping yang merugikan. Salah satu solusi untuk mengurangi kecemasan saat melahirkan dan nyeri persalinan adalah dengan pemberian *deep tissue massage* dan dikombinasikan dengan *frangipani essensial oil*.

Deep Tissue Massage adalah salah satu tehnik inovasi manajemen nyeri dengan melakukan pijatan pada punggung. Massage bisa dilakukan menggunakan lotion, balsam atau oil massage agar memberikan rasa hangat dan terjadi dilatasi pada pembuluh darah local. Vasodilatasi pembuluh darah akan mengoptimalkan peredaran darah pada daerah massage yang mengakibatkan terjadinya peningkatan aktivitas sel sehingga mengurangi rasa sakit. Massage mampu menimbulkan terciptanya relaksasi fisik dan mental untuk meminimalkan nyeri. Massage di area punggung bawah mengakibatkan tubuh mengeksresi bahan analgesic alami yang disebut endorphin. Banyak ibu bersalin merasa nyaman jika menerima pijatan di punggung bawah dan penekakan di bagian os coccygis kadar hormone endorphine ibu bersalin yang menerima intervensi massage lebih tinggi dibanding yang tidak menerima intervensi.

Frangipani atau kamboja memiliki nama latin *Plumeria rubra* adalah salah satu bunga yang umum tumbuh di Indonesia khususnya Bali dan Jawa. Frangipani mudah untuk tumbuh di daerah tropis dan menyimpan air di akar, daun, bunga dan batang pohon. Studi literatur menunjukkan bahwa kamboja juga terdapat beberapa senyawa volatile yang menyebabkan bunga memiliki bau harum sehingga banyak digunakan sebagai campuran parfum, kosmetik dan aromaterapi. Aroma dari bunga frangipani dapat memberikan efek untuk bersantai dan rileks dari kelelahan psikologis dan kelelahan fisik pada manusia. Frangipani memiliki unsur senyawa triterpenoid, amyrin, geraniol, sitronelol, dan linalool yang memberikan efek relaksan dan mengurangi stress tubuh. Frangipani dapat

digunakan untuk tujuan estetika seperti produksi lulur tubuh, masker wajah dan minyak pijat. Aroma dari bunga frangipani dapat memberikan efek untuk bersantai dan rileks dari kelelahan psikologis dan kelelahan fisik pada manusia.

Sejauh ini pelaksanaan praktik persalinan yang ada di lahan hanya dilakukan berdasarkan standar asuhan intranatal care tanpa memberikan intervensi khusus untuk menurunkan nyeri persalinan bagi ibu. pada buku ini akan berisi tentang tinjauan Pustaka dari persalinan, deep back massage, frangipani essential oil, hasil atau efek dari pemberian deep back massage yang dikombinasi dengan frangipani essential oil pada nyeri persalinan kala 1 fase aktif serta mekanismenya.

BAB 2

TINJUAN UMUM PERSALINAN

A. Definisi Persalinan

Persalinan didefinisikan sebagai proses dimana hasil konsepsi yaitu janin dan plasenta yang telah memenuhi waktu cukup bulan yaitu 37-42 minggu akan dilekuarkan dari dalam uterus ke dunia luar melalui jalan lahir. Persalinan mencakup proses fisiologis yang memungkinkan serangkaian perubahan yang besar pada ibu. Pada akhir kehamilan, uterus secara progresif akan lebih sensitif sampai timbul kontraksi. Proses persalinan ini membutuhkan kontraksi yang teratur dan efektif sehingga mampu melebarkan dan menipiskan serviks mengakibatkan kepala janin dapat turun ke jalan lahir. Proses tersebut akan menimbulkan perubahan fisik yaitu ibu merasakan sakit pinggang dan perut serta perubahan psikis seperti cemas.

Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin pada kehamilan yang cukup bulan dengan lahir secara spontan presentasi belakang kepala berlangsung selama kurang lebih 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun janin.

B. Fisiologi Persalinan

Persalinan ditandai oleh adanya aktifitas myometrium yang paling lama dan besar kemudian melemah kearah serviks. Fundus mengalami perubahan dari organ yang lunak selama kehamilan dan berubah menjadi berkontraksi selama

proses persalinan untuk mendorong janin keluar melalui jalan lahir.

Dalam proses pengeluaran janin terdapat 7 gerakan janin dalam manuver selama proses persalinan agar janin dapat dilahirkan, yaitu:

1. Engangement

Engangement pada primigravida terjadi pada bulan terakhir kehamilan, sedangkan pada multigravida dapat terjadi pada awal persalinan. Masuknya kepala akan mengalami kesulitan bila saat masuk ke dalam panggul dengan sutura sagitalis dalam anteroposterior. Jika kepala masuk ke dalam pintu atas panggul dengan sutura sagitalis melintang di jalan lahir, tulang parietal kanan dan kiri sama tinggi, maka keadaan ini disebut sinklitismus.

Kepala pada saat melewati pintu atas panggul dapat juga dalam keadaan dimana sutura sagitalis lebih dekat ke promontorium atau ke symphysis maka hal ini disebut Asinklitismus. Ada dua macam asinklitismus. Asinklitismus posterior dan asinklitismus anterior.

- a. Asinklitismus Posterior Yaitu keadaan bila sutura sagitalis mendekati symphysis dan tulang parietal belakang lebih rendah dari pada tulang parietal depan. Terjadi karena tulang parietal depan tertahan oleh simfisis pubis sedangkan tulang parietal belakang dapat turun dengan mudah karena adanya lengkung sakrum yang luas.
- b. Asinklitismus Anterior Yaitu keadaan bila sutura sagitalis mendekati promontorium dan tulang parietal depan lebih rendah dari pada tulang parietal belakang.

2. Descent

Penurunan diakibatkan oleh kekuatan kontraksi rahim, kekuatan mengejan dari ibu, dan gaya berat kalau

pasien dalam posisi tegak. Berbagai tingkat 9 penurunan janin terjadi sebelum permulaan persalinan pada primigravida dan selama Kala I pada primigravida dan multigravida. Penurunan semakin berlanjut sampai janin dilahirkan, gerakan yang lain akan membantunya.

3. Fleksi

Fleksi sebagian terjadi sebelum persalinan sebagai akibat tonus otot alami janin. Selama penurunan, tahanan dari serviks, dinding pelvis, dan lantai pelvis menyebabkan fleksi lebih jauh pada tulang leher bayi sehingga dagu bayi mendekati dadanya. Pada posisi oksipitoanterior, efek fleksi adalah untuk mengubah presentasi diameter dari oksipitofrontal menjadi suboksipitoposterior yang lebih kecil. Pada posisi oksipitoposterior, fleksi lengkap mungkin tidak terjadi, mengakibatkan presentasi diameter yang lebih besar, yang dapat menimbulkan persalinan yang lebih lama.

4. Internal Rotation

Pada posisi oksipitoanterior, kapala janin, yang memasuki pelvis dalam diameter melintang atau miring, berputar, sehingga oksipito kembali ke anterior ke arah simfisis pubis. Putaran paksi dalam mungkin terjadi karena kepala janin bertemu penyangga otot pada dasar pelvis. Ini sering tidak tercapai sebelum bagian yang berpresentasi telah tercapai sebelum bagian yang berpresentasi telah mencapai tingkat spina iskhidika sehingga terjadilah engagement. Pada 10 posisi oksipitoposterior, kepala janin dapat 20 memutar ke posterior sehingga oksiput berbalik ke arah lubang sakrum.

Pilihan lainnya, kepala janin dapat memutar lebih dari 90 derajat menempatkan oksiput di bawah simfisis

pelvis sehingga berubah ke posisi oksipitoanterior. Sekitar 75% dari janin yang memulai persalinan pada posisi oksipitoposterior memutar ke posisi oksipitoanterior selama fleksi dan penurunan. Bagaimanapun, sutura sagital biasanya berorientasi pada poros anteriorposterior dari pelvis.

5. Ekstensi

Kepala yang difleksikan pada posisi oksipitoanterior terus menurun di dalam pelvis. Karena pintu bawah vagina mengarah ke atas dan ke depan, ekstensi harus terjadi sebelum kepala dapat melintasinya. Sementara kepala melanjutkan penurunannya, terdapat penonjolan pada perineum yang diikuti dengan keluarnya puncak kepala. Puncak kepala terjadi bila diameter terbesar dari kepala janin dikelilingi oleh cincin vulva. Suatu insisi pada perineum (episiotomi) dapat membantu mengurangi tegangan perineum disamping untuk mencegah peregangan dan perentangan jaringan perineum. Kepala dilahirkan dengan ekstensi yang cepat sambil oksiput, sinsiput, hidung, mulut, dan dagu melewati perineum.

Pada posisi oksipitoposterior, kepala dilahirkan oleh kombinasi ekstensi dan fleksi. Pada saat munculnya puncak kepala, pelvis tulang posterior dan penyangga otot diusahakan berfleksi lebih jauh. Dahi, sinsiput, 11 dan oksiput dilahirkan sementara janin mendekati dada. Sesudah itu, oksiput jatuh kembali saat kepala berekstensi, sementara hidung, mulut, dan dagu dilahirkan

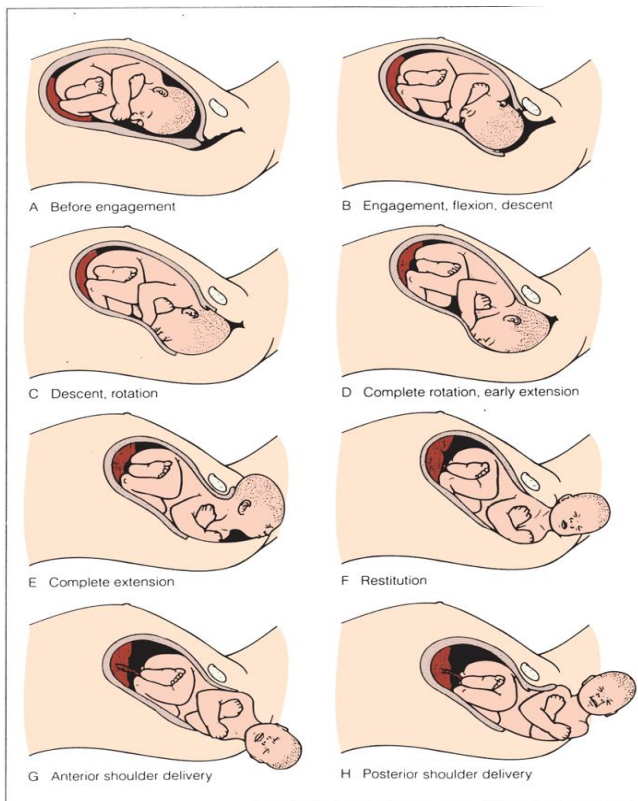
6. External Rotation

Pada posisi oksipitoanterior dan oksipitoposterior, kepala yang dilahirkan sekarang kembali ke posisi semula pada saat engagement untuk menyebariskan dengan

punggung dan bahu janin. Putaran paksi kepala lebih jauh dapat terjadi sementara bahu menjalani putaran paksi dalam untuk menyebariskan bahu itu di bagian anterior posterior di dalam pelvis.

7. Ekspulsi

Setelah putaran paksi luar dari kepala, bahu anterior lahir dibawah simfisis pubis, diikuti oleh bahu posterior di atas tubuh perineum, kemudian seluruh tubuh anak.



Gambar 1.1 Ekspulsi

C. Penyebab Terjadinya Persalinan

Penyebab terjadinya proses persalinan belum diketahui secara jelas, namun ada beberapa factor yang diketahui memiliki peranan penting sehingga terjadi persalinan. Berikut adalah beberapa teori terjadinya persalinan:

1. Penurunan kadar progesterone

Progesterone menimbulkan relaksasi otot-otot uterus, sebaliknya estrogen meningkatkan kerentanan otot rahim. Selama kehamilan terdapat keseimbangan antara kadar progesteron dan estrogen dalam darah, tetapi pada akhir kehamilan kadar progesteron mengalami penurunan sehingga otot – otot uterus yang semula berelaksasi mengalami his atau kontraksi

2. Teori oksitosin

Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis posterior. Perubahan keseimbangan estrogen dan progesterone dapat mengubah sensitivitas otot rahim, sehingga sering terjadi kontraksi Braxton Hicks. Di akhir kehamilan kadar progesteron menurun sehingga oksitocin bertambah dan meningkatkan aktivitas otot-otot rahim yang memicu terjadinya kontraksi sehingga terdapat tanda-tanda persalinan

3. Peregangan otot-otot

Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu. Setelah melewati batas tertentu terjadi kontraksi sehingga persalinan dapat dimulai. Seperti halnya dengan Bladder dan Lambung, bila dindingnya teregang oleh isi yang bertambah maka timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Demikian pula dengan rahim, maka dengan majunya kehamilan makin teregang otot-otot dan otot-otot rahim makin

rentan. Contoh, pada kehamilan ganda sering terjadi kontraksi setelah keregangan tertentu sehingga menimbulkan proses persalinan.

4. Pengaruh janin

Hipofise dan kelenjar suprarenal janin juga memegang peranan karena pada anencephalus kehamilan sering lebih lama dari biasa, karena tidak terbentuk hipotalamus. Pemberian kortikosteroid dapat menyebabkan maturasi janin, dan induksi (mulainya) persalinan

5. Teori prostaglandin

Konsentrasi prostaglandin meningkat sejak umur kehamilan 15 minggu yang dikeluarkan oleh desidua. Prostaglandin yang dihasilkan oleh desidua diduga menjadi salah satu sebab permulaan persalinan. Hasil dari percobaan menunjukkan bahwa prostaglandin F₂ atau E₂ yang diberikan secara intravena, intra dan extra amnial menimbulkan kontraksi miometrium pada setiap umur kehamilan. Pemberian prostaglandin saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga hasil konsepsi dapat keluar. Prostaglandin dapat dianggap sebagai pemicu terjadinya persalinan. Hal ini juga didukung dengan adanya kadar prostaglandin yang tinggi baik dalam air ketuban maupun daerah perifer pada ibu hamil, sebelum melahirkan atau selama persalinan

6. Teori janin

Terdapat hubungan hipofisis dan kelenjar suprarenal yang menghasilkan sinyal kemudian diarahkan kepada maternal sebagai tanda bahwa janin telah siap lahir. Namun mekanisme ini belum diketahui secara pasti

7. Teori berkurangnya nutrisi

Teori berkurangnya nutrisi pada janin diungkapkan oleh Hippocrates untuk pertama kalinya. Hasil konsepsi akan segera dikeluarkan bila nutrisi telah berkurang

8. Teori usia plasenta

Menjadi Tua Plasenta yang semakin tua seiring dengan bertambahnya usia kehamilan akan menyebabkan turunnya kadar estrogen dan progesteron sehingga timbul kontraksi Rahim

D. Tanda-Tanda Persalinan

Berikut adalah tanda-tanda jika persalinan sudah mulai dekat dirasakan:

1. Lightening, saat beberapa minggu sebelum persalinan, ibu akan merasakan keadaanya atau tubuhnya menjadi lebih ringan, sesaknya berkurang, tetapi sebaliknya akan terasa berat saat berjalan dan ada rasa nyeri di tubuh bagian bawah.
2. Pollikasuria, pada trimester ke 3, epigastrium mulai kendor, fundus akan menjadi rendah dan kepala janin sudah mulai masuk PAP. Keadaan inni menyebabkan adanya tekanan pada vesika urinaria sehingga mengurangi penyimpanan vesika urinaria dan merangsang ibu untuk sering kencing.
3. Energy sport, suatu keadaan dimana ibu akan secara tiba-tiba merasakan peningkatan energi sekitar 1-2 hari sebelum persalinan. Setelah beberapa hari di trimester 3 ibu cenderung mengalami kelelahan fisik.
4. Gastrointestinal upsets, adanya. Gangguan pada system pencernaan ibu akan mengalami tanda-tanda seperti diare, obstipasi, mual dan muntah karena efek penurunan hormone terhadap system pencernaan.

Sedangkan, berikut adalah tanda-tanda pasti dari **persalinan sebagai berikut:**

1. Kontraksi (His)

Ibu terasa adanya kontraksi atau kenceng-kenceng pada bagian perut bawah secara sering, teratur dengan nyeri yang menjalar dari pinggang ke paha. Hal ini disebabkan karena pengaruh hormone oksitosin yang secara fisiologi membantu dalam proses pengeluaran janin.

Terdapat 2 jenis kontraksi yang mungkin terasa pada ibu hamil yaitu kontraksi palsu (Braxton hicks) dan kontraksi yang sebenarnya. Pada kontraksi palsu yang dirasakan adalah kontraksi yang sebentar, tidak terlalu sering dan tidak teratur, serta tidak adanya peningkatan kekuatan kontraksi. Tidak semua ibu hamil akan merasakan kontraksi palsu. Sedangkan, untuk kontraksi sebenarnya ibu hamil akan merasakan kenceng-kenceng atau kontraksi yang frekuensinya semakin sering, waktu atau durasi semakin lama, dan intensitasnya semakin kuat, disertai mulas atau nyeri seperti kram pada perut. Kontraksi akan bersifat fundal recumbent/ nyeri yang dirasakan terjadi pada bagian atas atau tengah dari perut atau Rahim, pinggang dan panggul serta perut bagian bawah.

2. Pembukaan serviks (Primigravida > 1,8 cm dan Multigravida 2,2 cm)

Pada ibu hamil dengan kehamilan pertama, terjadinya proses pembukaan jalan lahir akan disertai nyeri pada perut. Sedangkan pada ibu hamil dengan kehamilan kedua atau lebih, pembukaan biasanya bisa tanpa diikuti rasa nyeri. Rasa nyeri ini terjadi karena adanya tekanan pada panggul karena terjadi proses

penurunan kepala janin ke daerah panggul sebagai akibat dari melunaknya rahim.

3. Pecahnya ketuban dan keluarnya Bloody Show

didalam uterus janin akan terbungkus oleh selaput amnion serta terdapat cairan ketuban sebagai cairan pelindung janin, agar janin bisa bergerak dan terhindar dari benturan luar. Cairan ketuban ini biasanya bisa terjaddi rembesan pada ibu karena selaputnya pecah. Cairan ini umumnya berwarna bening, tidak berbau, dan akan terus keluar sampai ibu melahirkan. Banyak ibu tidak sadar bahwa cairan ketubannya telah rembes sehingga ibu-ibu akan mengira itu adalah cairan air kencing. Pecahnya selaput ketuban yang diikuti pengeluaran cairan ketuban ini akan menimbulkan kontraksi atau nyeri yang lebih intensif.

Bloddy show atau disebut juga. Dengan lendir bercampur darah. Ini akan terjadi karena terjadinya proses pelunakan, pelebaran, dan penipisan dari serviks. Bloddy show akan terlihat seperti lendir yang kental bercampur darah dan keluar saat proses persalinan akan dimulai.

E. Faktor yang Mempengaruhi Persalinan

Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi persalinan antara lain:

1. Passenger

Passenger adalah janinnya sendiri, bagian paling besar dan keras pada janin adalah kepala janin, posisi dan besar kepala dapat mempengaruhi jalan persalinan. Biasanya apabila kepala janin sudah lahir, maka bagian-bagian lain dengan mudah menyusul lahir. Malpresentasi atau malformasi janin dapat mempengaruhi persalinan normal. Pada faktor passenger, terdapat beberapa faktor

yang mempengaruhi yakni ukuran kepala janin, presentasi, letak, sikap dan posisi janin. Karena plasenta juga harus melalui jalan lahir, maka ia dianggap sebagai penumpang yang menyertai janin.

2. Passage

Passage adalah kondisi jalan lahir yang terdiri dari panggul ibu, yakni bagian tulang yang padat, dasar panggul, vagina, dan introitus (lubang luar vagina). Jalan lahir memiliki peran penting dalam proses persalinan, karena itu evaluasi jalan lahir merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah persalinan dapat berlangsung pervaginam atau SC. Pada jalan lahir tulang dengan panggul ukuran normal apapun jenis kelahiran pervaginam janin dengan berat badan normal tidak akan mengalami masalah, akan tetapi karena pengaruh gizi dan lingkungan atau hal lain. Ukuran panggul dapat menjadi lebih kecil dari standar normal, sehingga bisa terjadi masalah dalam persalinan normal.

Meskipun jaringan lunak khususnya lapisan-lapisan otot dasar panggul ikut menunjang keluarnya bayi, tetapi panggul ibu jauh lebih berperan dalam proses persalinan. Janin harus berhasil menyesuaikan dirinya terhadap jalan lahir yang relatif kaku.

3. Power

His adalah salah satu kekuatan pada ibu yang menyebabkan serviks membuka dan mendorong janin ke bawah. Kontraksi uterus berirama teratur dan involunter serta mengikuti pola yang berulang. Setiap kontraksi uterus memiliki 3 fase yaitu increment (Ketika intensitasnya terbentuk), acme (puncak atau maksimum), dan decement (Ketika relaksasi). Pada presentasi kepala, bila his sudah cukup kuat, kepala akan turun dan mulai

masuk ke dalam rongga panggul.

Kontraksi uterus terjadi karena adanya penimbunan dan pengikatan kalsium pada reticulum endoplasma (RE) yang bergantung pada ATP dan sebaliknya E2 dan F2 akan mencegah penimbunan dan peningkatan ATP pada RE, RE membebaskan kalsium ke dalam intra seluler dan menyebabkan kontraksi myofibril. Setelah myofibril berkontraksi, kalsium Kembali lagi ke RE sehingga kadar kalsium intaseluler akan berkurang dan menyebabkan relaksasi myofibril.

4. Position

Posisi ibu mempengaruhi adaptasi anatomi dan fisiologi persalinan. Posisi tegak memberi sejumlah keuntungan. Mengubah posisi membuat rasa letih hilang, memberi rasa nyaman, dan memperbaiki sirkulasi. Posisi tegak meliputi posisi berdiri, berjalan, duduk dan jongkok

5. Psychologic Respons

Proses persalinan adalah saat yang menegangkan dan mencemaskan bagi wanita dan keluarganya. Rasa takut, tegang dan cemas mungkin mengakibatkan proses kelahiran berlangsung lambat. Pada kebanyakan wanita, persalinan dimulai saat terjadi kontraksi uterus pertama dan dilanjutkan dengan kerja keras selama jamjam dilatasi dan melahirkan kemudian berakhir ketika wanita dan keluarganya memulai proses ikatan dengan bayi. Perawatan ditujukan untuk mendukung wanita dan keluarganya dalam melalui proses persalinan supaya dicapai hasil yang optimal bagi semua yang terlibat. Wanita yang bersalin biasanya akan mengutarakan berbagai kekhawatiran jika ditanya, tetapi mereka jarang dengan spontan menceritakannya.

Selama proses persalinan normal, ibu menjalani dengan perjuangannya, sehingga ibu harus memiliki kepercayaan diri bahwa ibu mampu untuk menjalani proses persalinan. Ibu bersalin harus memiliki keyakinan bahwa ia mampu menjalani proses persalinan dengan mudah dan lancar. Ibu yang memiliki keyakinan yang positif maka akan emningkatan kepercayaan diri ibu dan ibu memiliki kekuatan untuk proses persalinan.

F. Tahapan Persalinan

1. Kala I

Kala I persalinan dimulai dengan kontraksi uterus yang teratur dan diakhiri dengan dilatasi serviks lengkap. Dilatasi lengkap dapat berlangsung kurang dari satu jam pada sebagian kehamilan multipara. Pada kehamilan pertama, dilatasi serviks jarang terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Rata-rata durasi total kala I persalinan pada primigravida berkisar dari 3,3 jam sampai 19,7 jam. Pada multigravida ialah 0,1 sampai 14,3. Ibu akan dipertahankan kekuatan moral dan emosinya karena persalinan masih jauh sehingga ibu dapat mengumpulkan kekuatan. Proses membukanya serviks sebaga akibat his dibagi dalam 2 fase, yaitu:

- a. Fase laten: merupakan periode awal persalinan hingga Ketika pembukaan mulai berjalan secara progresif, umumnya dimulai sejak kontraksi muncul sampai pembukaan 3 berlangsung selama 8 jam. Pembukaan terjadi sangat lambat sampai mencapai ukuran diameter 3 cm. Fase laten diawali dengan mulai timbulnya kontraksi uterus yang teratur yang menghasilkan perubahan serviks.

b. Fase aktif: merupakan periode waktu awal kemajuan aktif pembukaan menjadi komplit. Terjadi penurunan bagian presentasi janin yang progresif selama akhir fase aktif dan selama kala 2. dibagi dalam 3 fase lagi yakni:

- 1) Fase akselerasi yaitu dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm tadi menjadi 4 cm.
- 2) Fase dilatasi maksimal yaitu dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm.
- 3) Fase deselerasi yaitu pembukaan menjadi lambat kembali. Dalam waktu 2 jam, pembukaan dari 9 cm menjadi lengkap.

Durasi fase laten sangat sensitif terhadap pengaruh dari luar dan mungkin memanjang oleh sedasi hebat atau memendek dengan stimulasi. Sensitivitas ini pada intervensi memberi praktisi kesempatan untuk mencoba memperpendek lama fase laten. Filosofi pemberi pelayanan dan keinginan klien sering menjadi faktor keputusan apakah memberi intervensi dengan sedasi atau stimulasi. Saat ini kedua metode dapat digunakan untuk meniadakan fase laten yang lama

2. Kala II

Kala II persalinan adalah tahap di mana janin dilahirkan. Pada kala II, his menjadi lebih kuat dan lebih cepat, kira-kira 2 sampai 3 menit sekali. Saat kepala janin sudah masuk di ruang panggul, maka pada his dirasakan tekanan pada otot-otot dasar panggul, yang secara reflektoris menimbulkan rasa mencedakan. Wanita merasakan tekanan pada rektum dan hendak buang air besar. Kemudian perineum mulai menonjol dan menjadi lebar dengan anus membuka. Labia mulai membuka dan

tidak lama kemudian kepala janin tampak dalam vulva pada waktu his. Dengan his dan kekuatan mengedan maksimal, kepala janin dilahirkan dengan presentasi suboksiput di bawah simfisis, dahi, muka dan dagu.

Batas dan lama tahap persalinan kala II berbeda-beda tergantung paritasnya. Durasi kala II dapat lebih lama pada wanita yang mendapat blok epidural dan menyebabkan hilangnya refleks mengedan. Pada Primigravida, waktu yang dibutuhkan dalam tahap ini adalah 25-57 menit. Rata-rata durasi kala II yaitu 50 menit. Pada tahap ini, jika ibu merasa kesepian, sendiri, takut dan cemas, maka ibu akan mengalami persalinan yang lebih lama dibandingkan dengan jika ibu merasa percaya diri dan tenang.

Pada kala II umumnya kepala janin sudah masuk PAP, Ketuban yang menonjol biasanya akan pecah sendiri. Apabila belum pecah maka ketuban harus dipecahkan. Kontraksi akan datang lebih sering dan kuat, lalu disela itu akan timbul his disertai ingin mengejan secara spontan.

3. Kala III

Kala III persalinan berlangsung sejak janin lahir sampai plasenta lahir. Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dengan fundus uteri agak di atas pusat. Beberapa menit kemudian, uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari dindingnya. Biasanya plasenta lepas dalam 6 sampai 15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri. Adapun fisiologi kala III persalinan sebagai berikut:

- a. Lepasnya plasenta dari implantasi pada dinding uterus
Pada kala III, myometrium akan berkontraksi mengikuti penyusutan volume rongga uterus. Penurunan ukuran volume ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat

perlekatan plasenta. Saat ukuran tempat perlekatan plasenta semakin kecil dan plasenta ukurannya tetap maka plasenta akan terlipat dan menebal kemudian lepas dari uterus.

b. Pengeluaran plasenta dari cavum uteri

Proses pengeluaran plasenta dari cavum uteri dilakukan setelah memastikan plasenta telah lepas dari perlekatannya. Tanda tanda lepasnya plasenta mencakup beberapa hal seperti adanya perubahan bentuk dan tinggi fundus, tali pusat yang memanjang, adanya semburan darah.

Manajemen aktif kala III meliputi pemberian oksitosin dengan segera, pengendalian tarikan pada tali pusat, dan pemijatan uterus segera setelah plasenta lahir. Jika menggunakan manajemen aktif dan plasenta belum juga turun dalam waktu 30 menit, maka kandung kemih harus diperiksa dan dilakukan kateterisasi, periksa Kembali adanya pelepasan plasenta, dan berikan tambahan oksitosin 10 unit (IM).

4. Kala IV

Kala IV persalinan ditetapkan berlangsung kira-kira dua jam setelah plasenta lahir. Periode ini merupakan masa pemulihan yang terjadi segera jika homeostasis berlangsung dengan baik. Pada tahap ini, kontraksi otot rahim meningkat sehingga pembuluh darah terjepit untuk menghentikan perdarahan. Pada kala ini dilakukan observasi terhadap tekanan darah, pernapasan, nadi, kontraksi otot rahim dan perdarahan selama 2 jam pertama.

G. Asuhan Sayang Ibu pada Masa Persalinan

Asuhan persalinan diberikan untuk mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat Kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya. Berikut adalah beberapa upaya atau asuhan sayang ibu yang bisa diberikan pada ibu dalam proses bersalin:

1. Kala 1

Kala I adalah suatu kala dimana dimulai dari timbulnya his sampai pembukaan lengkap. Asuhan yang dapat dilakukan pada ibu adalah:

- a. Memberikan dukungan emosional
- b. Pendampingan anggota keluarga selama proses persalinan
- c. Menghargai keinginan ibu untuk memilih pendamping persalinan
- d. Peran aktif anggota keluarga selama persalinan (memberikan masase pada tubuh ibu, membantu ibu bernafas dengan benar saat kontraksi, word of affirmation, menciptakan suasana kekeluargaan yang aman)
- e. Mengatur posisi ibu sehingga terasa nyaman
- f. Memberikan cairan, nutrisi dan hidrasi
- g. Pencegahan infeksi

2. Kala II

Kala II adalah kala dimana dari pembukaan lengkap sampai keluarnya bayi. Asuhan yang dapat dilakukan pada ibu adalah:

- a. Pendampingan selama proses persalinan sampai bayi lahir
- b. Keterlibatan keluarga atau pendamping seperti membantu berganti posisi, melakukan rangsangan taktil, memberi dukungan semangat

- c. Keterlibatan penolong persalinan selama proses persalinan seperti memberikan dukungan, menjelaskan tahapan persalinan, melakukan pendampingan
- d. Mengajarkan ibu meneran jika ada dorongan kuat dan spontan untuk meneran
- e. Memberikan rasa aman dan nyaman
- f. Pencegahan infeksi
- g. Membantu ibu mengosongkan kandung kemih

3. Kala III

Kala III adalah kala dimana dimulai dari keluarnya bayi sampai plasenta lahir. Asuhan yang dapat dilakukan pada ibu adalah:

- a. Memberikan kesempatan kepada ibu untuk memeluk bayinya dan menyusui segera
- b. Memberitahu setiap tindakan yang akan dilakukan
- c. Pencegahan infeksi pada kala III
- d. Memantau keadaan ibu (tanda vital, kontraksi, perdarahan)
- e. Melakukan kolaborasi/rujukan bila terjadi kegawatdaruratan
- f. Pemenuhan kebutuhan nutrisi dan hidrasi
- g. Memberikan motivasi dan pendampingan selama kala III

4. Kala IV

Kala IV adalah kala dimana 1-2 jam setelah lahirnya plasenta. Asuhan yang dapat dilakukan pada ibu adalah:

- a. Memastikan tanda vital, kontraksi uterus, perdarahan dalam keadaan normal
- b. Membantu ibu untuk berkemih
- c. Mengajarkan ibu dan keluarganya tentang cara menilai kontraksi dan melakukan massase uterus

- d. Menyelesaikan asuhan awal bagi bayi baru lahir
- e. Mengajarkan ibu dan keluarganya ttg tanda-tanda bahaya post partum seperti perdarahan, demam, bau busuk dari vagina, pusing, lemas, penyulit dalam menyusui bayinya dan terjadi kontraksi hebat
- f. Pemenuhan kebutuhan nutrisi dan hidrasi
- g. Pendampingan pada ibu selama kala IV
- h. Nutrisi dan dukungan emosional

BAB 3

NYERI PERSALINAN

A. Definisi Nyeri Persalinan

The International Association for the Study of Pain (IASP) mendefinisikan nyeri sebagai sebuah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, yang berhubungan dengan atau menyerupai kerusakan jaringan aktual dan potensial. Nyeri persalinan adalah perasaan sakit akibat kontraksi rahim dan diterima sebagai bagian dari proses melahirkan. Nyeri persalinan selalu menghantui ibu hamil, terutama pada primipara. Nyeri dapat bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh banyak faktor.

Nyeri persalinan merupakan pengalaman yang kompleks dan multidimensi yang terjadi selama persalinan. Nyeri persalinan digambarkan sebagai nyeri paling parah yang pernah dialami oleh sebagian besar perempuan di mana mayoritas ibu bersalin mengeluhkan nyeri yang mereka rasakan sebagai nyeri yang hebat atau sangat hebat. Nyeri persalinan yang tidak diobati telah dijelaskan sebagai penyebab nyeri kronis, sindrom stres pascapersalinan, dan konsekuensi psikologis dan fisiologis yang tidak diinginkan. Nyeri dan kecemasan menyebabkan pelepasan adrenalin yang menyebabkan persalinan lama dan peningkatan kadar noradrenalin sebesar 25% menurunkan hingga 50%. Curah

jantung ibu, resistensi vaskular sistemik dan kebutuhan oksigen akan meningkat.

B. Faktor yang Mempengaruhi Nyeri Persalinan

Nyeri persalinan disebabkan oleh serangkaian faktor fisiologis seperti kontraksi uterus dan dilatasi serviks beserta faktor mental dan emosional termasuk rasa takut dan cemas. Selain itu, faktor-faktor seperti usia ibu, paritas, kekuatan fisik wanita saat persalinan, dan status ibu dapat memengaruhi tingkat keparahan dan durasinya. Usia berhubungan dengan nyeri persalinan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa usia yang lebih muda berhubungan dengan laporan nyeri persalinan yang lebih intens. Sebuah penelitian menemukan bahwa nyeri selama awal persalinan berkurang secara signifikan seiring bertambahnya usia. Perempuan yang lebih tua biasanya multipara sehingga kontraksi uterus yang kurang intens dan serviks sudah lebih lunak dibandingkan dengan wanita yang lebih muda.

Paritas mempengaruhi nyeri persalinan. Multipara mengalami nyeri yang lebih sedikit daripada primipara pada fase laten, fase aktif, dan fase transisi. Pengalaman pertama nyeri persalinan ditemukan sangat hebat pada wanita primipara. Stimulasi nociceptor pelvis dan serviks yang lebih kuat oleh kepala janin menyebabkan nyeri yang lebih hebat pada wanita primipara. Alasan mengapa nyeri pada fase laten pada primipara lebih tinggi daripada multipara adalah karena dilatasi serviks hanya mengalami sedikit kemajuan sebelum pendataran berlangsung lama, sedangkan pada multipara, keduanya dapat terjadi secara bersamaan.

Faktor janin berperan dalam timbulnya intensitas nyeri persalinan. Berat, posisi, dan letak janin dapat memengaruhi nyeri persalinan. Berat janin yang lebih besar dikaitkan

dengan nyeri persalinan yang lebih hebat, berat janin yang besar menyebabkan tekanan janin pada tahap pertama dan tahap kedua persalinan lebih kuat. Posisi oksipital posterior janin merupakan penyebab utama nyeri punggung yang hebat selama persalinan. Perempuan yang janinnya berada pada posisi oksipital posterior cenderung merasakan nyeri yang lebih hebat pada fase laten. Janin yang lebih besar lebih sulit saat melewati jalan lahir dan janin yang lebih banyak dapat menyebabkan rahim meregang berlebihan, sehingga kontraksi akan lebih menyakitkan.

Salah satu faktor yang memengaruhi nyeri persalinan adalah faktor psikologi. Penyebab nyeri pada aspek psikologi dipengaruhi kecemasan ibu, ketakutan akan nyeri persalinan, dan rasa kontrol fisik dan psikologis selama persalinan, kekhawatiran tentang diri sendiri dan bayi, pengalaman persalinan sebelumnya serta ekspektasi ibu tentang persalinan dan nyeri. Ketakutan dan kecemasan dapat meningkatkan persepsi nyeri dengan meningkatkan ketegangan dan resistensi otot. Rasa percaya diri, relaksasi, ketenangan selama proses persalinan, dan dukungan yang optimal cenderung menurunkan intensitas nyeri yang dirasakan selama proses persalinan. Persiapan psikologis dalam menghadapi proses persalinan dapat mengurangi penggunaan analgesia dan meningkatkan keberhasilan manajemen nyeri persalinan.

Faktor sosial budaya, kepercayaan budaya, dan sikap masyarakat terhadap persalinan dapat memengaruhi harapan dan strategi penanganan persalinan. Dalam beberapa budaya, nyeri persalinan dipandang sebagai bagian alami dari persalinan, sementara di budaya lain, nyeri persalinan dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti. Selain itu, dukungan sosial sangat penting

selama persalinan. Memiliki pendamping yang mendukung dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman nyeri seorang perempuan dan mengurangi kebutuhannya akan analgesia farmakologi.

Status sosial ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab nyeri persalinan. Dalam beberapa penelitian di Amerika, ditemukan bahwa perempuan dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi mengalami lebih sedikit nyeri dan lebih bahagia selama persalinan dan melahirkan serta lebih optimis tentang kehamilan dan persalinan mereka. Perempuan dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi lebih cenderung lebih siap dalam menghadapi persalinannya. Perempuan dengan status sosial ekonomi yang kurang cenderung menilai nyeri persalinan sebagai hal yang menyiksa.

Dukungan penolong persalinan memiliki efek pada nyeri persalinan. Sebuah penelitian terhadap 200 wanita Finlandia menunjukkan bahwa sumber utama dukungan emosional bagi wanita selama persalinan berasal dari penolong persalinan. Sebuah penelitian deskriptif terhadap 13 wanita pascapersalinan menunjukkan bahwa penjelasan dan respons penolong persalinan terhadap kebutuhan perempuan selama persalinan memengaruhi pengalaman persalinan yang lebih positif.

C. Mekanisme Terjadinya Nyeri Persalinan

Nyeri persalinan memiliki dua komponen, visceral dan somatik. Nyeri persalinan visceral terjadi selama tahap pertama dan kedua persalinan. Tahap pertama persalinan berasal dari serviks, uterus, dan adneksa. Pada setiap kontraksi uterus, tekanan ditransmisikan ke serviks yang menyebabkan peregangan dan distensi serta mengaktifkan aferen nosioseptif eksitatori. Nyeri dimediasi oleh serabut

Asuhan Kebidanan Persalinan: Intervensi Deep Back Massage
Menggunakan Frangipani Essensial Oil Terhadap Penurunan Nyeri
Persalinan Kala 1 Fase Aktif

simpatis yang mengirimkan sinyal ke ganglia akar saraf posterior yang terletak di tingkat spinal T10-L1. Nyeri visceral disalurkan oleh serabut 'C' kecil tak bermielin yang berjalan bersama serabut simpatis dan melewati plexus saraf uterus, serviks, dan hipogastrikus ke dalam rantai simpatis utama. Serabut nyeri dari rantai simpatis memasuki rami komunikans putih yang terkait dengan saraf tulang belakang T10 hingga L1 dan melewati akar saraf posteriornya untuk bersinaps di kornua dorsalis sumsum tulang belakang. Beberapa serabut menyilang di tingkat kornua dorsalis dengan ekstensi rostral dan kaudal yang luas sehingga menyebabkan nyeri yang tidak terlokalisasi dengan baik. Mediator kimia yang terlibat meliputi bradikinin, leukotrien, prostaglandin, serotonin, substansi P, dan asam laktat.

Nyeri somatik dihantarkan oleh serabut halus bermielin yang bertransmisi cepat melalui 'A delta'. Nyeri di salurkan melalui saraf pudendal dan cabang perineal saraf kutan posterior paha ke akar saraf S2 - S4. Serabut somatik dari cabang kutan saraf ilioinguinal dan genitofemoral juga membawa serabut aferen ke L1 dan L2. Nyeri somatik terjadi mendekati persalinan, bersifat tajam dan mudah terlokalisasi di vagina, rektum, dan perineum. Nyeri ini menjalar ke dermatom T10 dan L1 yang berdekatan dan dibandingkan dengan nyeri visceral, lebih resistan terhadap obat opioid.

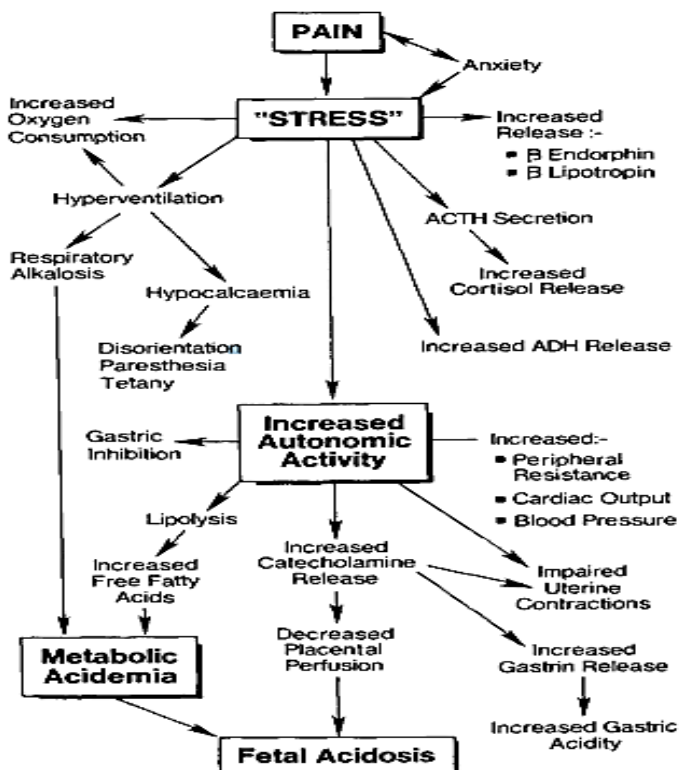
Semua impuls saraf yang dihasilkan (visceral dan somatik) diteruskan ke sel-sel tanduk dorsal, tempat impuls tersebut diproses dan ditransmisikan ke otak melalui traktus spinothalamikus. Transmisi ke sistem hipotalamik dan limbik menghasilkan respons emosional dan otonom yang terkait dengan nyeri.

D. Dampak Nyeri Persalinan

Nyeri persalinan yang parah memengaruhi kesehatan ibu dan janin secara negatif dengan memperburuk kesehatan emosional dan mental ibu. Nyeri ini menyebabkan peningkatan curah jantung dan ventilasi paru, kebutuhan oksigen, kontraksi uterus yang tidak efektif, persalinan yang lama, penurunan perfusi uterus, asidosis metabolik, dan peningkatan intervensi obstetrik, hipoksia pada janin, dan penurunan skor Apgar.

Nyeri merangsang sistem pernapasan berdampak pada peningkatan ventilasi pernapasan, peningkatan konsumsi oksigen, dan hiperventilasi yang dapat menyebabkan alkalosis pernapasan dan penurunan jumlah darah yang diangkut ke janin. Selain itu, nyeri, kecemasan, dan stres selama persalinan dapat menyebabkan peningkatan pelepasan katekolamin dan kortisol ke dalam sirkulasi, yang meningkatkan komplikasi feto-maternal.

Nyeri persalinan yang hebat berdampak negatif pada ibu dan janin. Nyeri hebat saat persalinan dilaporkan mengganggu fungsi otonom ibu dan menyebabkan pelepasan katekolamin sehingga mengakibatkan persalinan abnormal dan gawat janin, penghambatan aktivitas uterus, kontraksi uterus abnormal, persalinan lama, dan peningkatan risiko masalah intra-partum.



Gambar 3.1 Dampak negatif nyeri persalinan

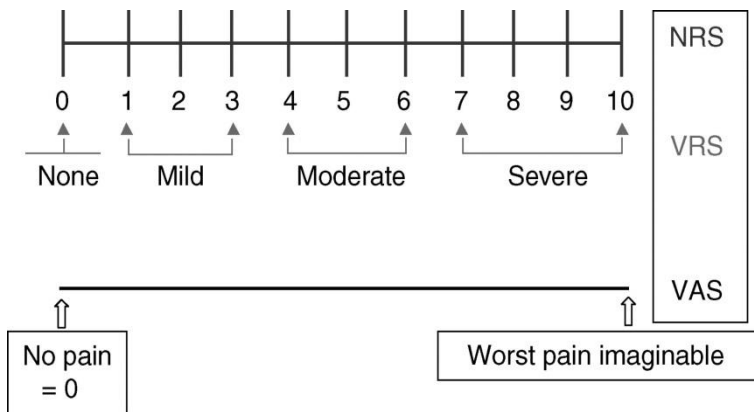
Nyeri hebat selama proses persalinan menyebabkan hiperventilasi selama kontraksi uterus. Periode hiperventilasi yang berkepanjangan menyebabkan hipokarbia maternal (PaCO_2 15-20 mmHg) dan alkalosis pernapasan (pH 7,55-7,60). Hipokarbia memicu gejala seperti mual, kelelahan, pusing, kebingungan mental dan disorientasi, parestesia (sekunder akibat hipokalsemia), kulit pucat dan berkeringat. Hipokarbia juga menggeser kurva disosiasi oksigen maternal ke kiri, sehingga mengurangi transfer oksigen jaringan; sementara alkalosis pernapasan menyebabkan ekskresi bikarbonat ginjal kompensasi sehingga berkontribusi terhadap asidosis metabolik maternal. Nyeri hebat selama

proses persalinan dikaitkan dengan peningkatan konsumsi oksigen.

Tekanan darah meningkat secara progresif seiring dengan kemajuan persalinan. Kecepatan darah berkurang hingga 80% selama kontraksi. Nyeri persalinan tidak hanya memicu asidosis ibu, tetapi juga asidosis pada janin. Selama kala dua, laju perkembangan asidosis janin dipercepat oleh tindakan mengejan. Nyeri persalinan menimbulkan respons stres umum yang memiliki efek fisiologis luas pada ibu dan janin.

E. Skala Pengukuran Nyeri Persalinan

Skala nyeri adalah alat yang membantu pasien mengukur dan mengkomunikasikan tingkat nyeri yang dirasakan untuk membantu dalam proses manajemen nyeri. Skala pengukuran nyeri yang umum digunakan adalah *Numeric Rating Scale* (NRS), *Visual Analog Scale* (VAS), dan *Verbal Rating/Descriptor Scale* (VRS/VDS).



Gambar 3.2 *Numeric Rating Scale* (NRS), *Visual Analog Scale* (VAS), dan *Verbal Rating/Descriptor Scale* (VRS/VDS)

NRS merupakan versi modifikasi dari VAS yang terdiri dari skala numerik tersegmentasi dengan 11 poin yang berkisar dari 0 hingga 10. NRS hanya mengevaluasi intensitas nyeri. NRS adalah alat yang umum digunakan yang mengharuskan pasien menilai nyerinya pada skala 0 hingga 10, dengan 0 menunjukkan tidak ada nyeri dan 10 menunjukkan nyeri terburuk yang mungkin terjadi. NRS dapat digunakan pada anak-anak yang mampu memahami angka. Skor nyeri diinterpretasikan sebagai 0 = tidak nyeri, 1–3 = nyeri ringan, 4–6 = nyeri sedang, dan 7–10 = nyeri parah.

VAS adalah alat yang paling banyak digunakan untuk memperkirakan tingkat keparahan nyeri dan menilai sejauh mana nyeri berkurang. Biasanya berupa garis horizontal, panjangnya 100 mm, yang ditambahkan oleh deskriptor kata di setiap ujungnya, misalnya, yang mewakili tingkat keparahan gejala dari 0 "tidak ada gejala" hingga 10 "gejala sangat parah." Pasien menandai titik pada garis yang diyakini pasien mewakili persepsinya tentang kondisinya saat ini. Skor VAS ditentukan dengan mengukur dalam milimeter dari ujung kiri garis ke titik yang ditandai pasien. Pada pemeriksaan nyeri menggunakan VAS, petugas kesehatan meminta pasien untuk memilih titik pada garis yang ditarik di antara dua ujung untuk mengekspresikan seberapa intens pasien merasakan nyeri. Pasien diminta untuk menilai intensitas nyeri "saat ini" atau intensitas nyeri "dalam 24 jam terakhir". VAS adalah instrumen yang mudah digunakan yang tidak memerlukan penggunaan perangkat yang canggih.

VRS atau skala penilaian verbal adalah alat untuk mengukur tingkat keparahan nyeri yang menggunakan kata-kata. Dalam VRS, pasien diberikan pilihan respons untuk

menggambarkan tingkat keparahan gejala, misalnya: *none* (tidak nyeri), *mild* (nyeri ringan), *moderate* (nyeri sedang), *severe* (nyeri parah). VRS merupakan salah satu skala yang digunakan untuk mengukur hasil yang dilaporkan pasien. Kekurangan dari VRS adalah membatasi pilihan kata klien sehingga tidak dapat membedakan berbagai tipe nyeri.

F. Strategi Manajemen Nyeri Persalinan

Ketakutan terhadap nyeri persalinan diketahui sebagai salah satu alasan meningkatnya angka operasi caesar. Nyeri persalinan merupakan fenomena fisiologis dan masalah psikososial yang dapat membahayakan seorang perempuan. Hal ini menyebabkan perempuan mengalami gejala stres, penyesalan atas keputusan melahirkan normal, dan permintaan operasi caesar. Penatalaksanaan nyeri persalinan merupakan aspek serius dari perawatan obstetrik dan tujuan utama perawatan terkait persalinan.

Nyeri persalinan yang parah memengaruhi kesehatan ibu dan janin secara negatif dengan memperburuk kesehatan emosional dan mental ibu. Nyeri ini menyebabkan peningkatan curah jantung dan ventilasi paru, kebutuhan oksigen, kontraksi uterus yang tidak efektif, persalinan yang lama, penurunan perfusi uterus, asidosis metabolik, dan peningkatan intervensi obstetrik, hipoksia pada janin, dan penurunan skor Apgar. Karena dampak nyeri persalinan yang parah pada ibu dan janin, American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) dan American Society of Anesthesiologists (ASA) telah melaporkan bahwa nyeri persalinan harus diredakan dan mereka menganggap nyeri persalinan sebagai indikasi pengobatan. Metode farmakologis dan nonfarmakologis digunakan untuk meredakan nyeri persalinan.

Metode pengendalian nyeri farmakologis yang digunakan selama persalinan adalah analgesik sistemik (obat penenang, sedatif), analgesia inhalasi, analgesia regional (blok paraservikal, blok pudendal, blok epidural lumbal-kaudal, blok spinal, blok spinal-epidural gabungan, blok simpatis lumbal), analgesia lokal, dan anestesi umum. Metode nonfarmakologis yang digunakan untuk nyeri persalinan dapat dicantumkan sebagai teknik pernapasan, pijat, sentuhan, effleurage, aplikasi panas atau dingin, hidroterapi, gerakan dan posisi, pemfokusan dan pengalihan, hipnosis, metode persiapan persalinan, dukungan persalinan, membayangkan, musik, aromaterapi, akupuntur, akupresur (Shiatsu), refleksiologi, homeopati, aplikasi stimulasi saraf listrik subkutan (TENS), dan injeksi air steril perkutan atau subkutan.

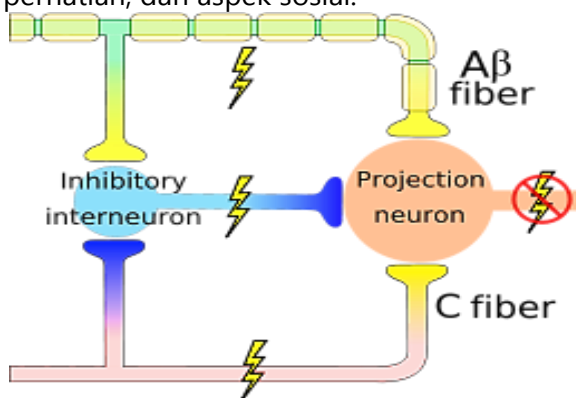
Ada bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan metode farmakologis untuk meredakan nyeri persalinan dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Metode nonfarmakologis yang noninvasif aman bagi kesehatan ibu dan bayi serta mengurangi kemungkinan intervensi obstetri menjadi pilihan yang paling utama bagi ibu bersalin saat ini. Selain itu, dukungan tanpa henti yang diberikan kepada wanita selama persalinan mengurangi komplikasi klinis sebelum dan selama persalinan dan pada periode pascapersalinan serta meningkatkan kepuasan terhadap pengalaman persalinan. Perempuan yang menggunakan metode nonfarmakologis selama persalinan memiliki skor nyeri yang lebih rendah, mampu mengatasi nyeri persalinan dengan lebih mudah, dan memiliki pengalaman persalinan yang lebih positif.

Dukungan persalinan berkelanjutan (dukungan fisik dan emosional) merupakan salah satu metode

nonfarmakologis yang paling banyak digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri, dan memiliki banyak keuntungan seperti waktu persalinan yang lebih singkat, mengurangi kebutuhan oksitosin, analgesia, persalinan dengan alat bantu, dan mengurangi operasi caesar hingga 50%. Penyedia layanan kesehatan harus mendampingi ibu selama proses persalinan dan memastikan bahwa persalinan berlangsung dengan aman dengan memberikan dukungan tanpa gangguan.

G. Gate Control Theory

Gate Control Theory atau "teori gerbang kendali nyeri" dikembangkan oleh Melzack dan Wall pada tahun 1965. Teori ini menyebutkan bahwa sinyal nyeri dimodulasi oleh mekanisme 'gerbang' di dalam sumsum tulang belakang. Sinyal nyeri tidak ditransmisikan secara pasif dari perifer ke otak, tetapi dimodulasi oleh mekanisme 'gerbang' yang terletak di sumsum tulang belakang. Gerbang ini dapat memperkuat atau menghambat transmisi sinyal nyeri berdasarkan berbagai faktor, termasuk kondisi psikologis, fokus perhatian, dan aspek sosial.



Gambar 3.3 Mekanisme *gate control theory*

Saraf aferen yang menerima nyeri dan membawa sinyal ke otak, terdiri dari dua jenis serabut, serabut "A δ " yang bersifat cepat, relatif tebal, dan bermielin yang membawa pesan dengan cepat dengan nyeri yang hebat, dan serabut "C" yang kecil, tidak bermielin, dan lambat dalam membawa nyeri berdenyut dan kronis dalam jangka panjang. Serabut A β berdiameter besar bersifat nonnosiseptif (tidak mengirimkan rangsangan nyeri) dan menghambat efek penembakan oleh serabut A δ dan C.

Sistem saraf tepi memiliki pusat pengaturan rangsangan nyeri. Beberapa area di kornua dorsalis sumsum tulang belakang yang terlibat dalam penerimaan rangsangan nyeri dari serabut A δ dan C, yang disebut lamina yang juga menerima masukan dari serabut A β . Serabut nonnosiseptif secara tidak langsung menghambat efek serabut nyeri, 'menutup gerbang' terhadap transmisi rangsangannya. Di bagian lamina lainnya, serabut nyeri juga menghambat efek serabut nonnosiseptif, 'membuka gerbang'.

Gate Control Theory akan mengakomodir variabel psikologi dalam persepsi nyeri, termasuk motivasi untuk bebas dari rasa nyeri serta peranan pikiran, emosi dan reaksi stress dalam meningkatkan atau menurunkan sensasi nyeri. Melalui teori ini dapat dipahami bahwa nyeri dapat dikontrol oleh manipulasi farmakologis dan intervensi psikologis. Respon terhadap nyeri juga bisa dipengaruhi oleh motivasi dan emosional.

Dalam *Gate Control Theory*, variabel psikologis memiliki fungsi penting dalam persepsi nyeri. Menurut teori ini, faktor latar belakang, harapan, dan keadaan emosional seseorang memainkan peran penting dalam pengalaman nyeri. Pemahaman tentang bagaimana harapsan dan emosi selama kehamilan memengaruhi nyeri persalinan akan

menjadi langkah penting dalam persiapan perempuan dalam menghadapi persalinan.

BAB 4

DEEP BACK MASSAGE

A. Definisi *Deep Back Massage*

Massage adalah teknik kuno yang menggunakan peregangan dan tekanan dalam ritme yang berirama. Massage membantu meredakan ketegangan pada otot-otot tertentu, meningkatkan rileksasi, meredakan stres dan nyeri, menurunkan tekanan darah, membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mempercepat proses pemulihan. Terapi ini melibatkan upaya manipulasi jaringan lunak superfisial kulit, otot, tendon, ligamen, dan fascia serta struktur yang terletak di dalam jaringan superfisial untuk tujuan terapeutik.

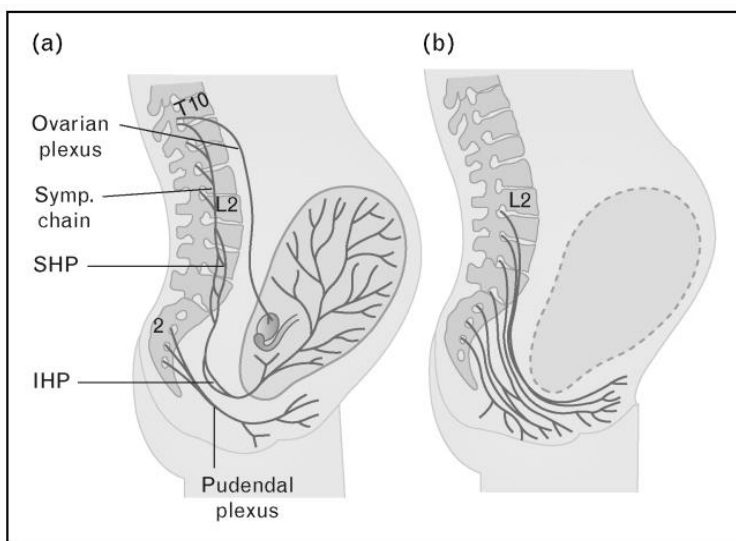
Massage dalam kebidanan berfungsi sebagai terapi komplementer yang mendukung kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan masa nifas. Teknik ini melibatkan manipulasi jaringan lunak untuk meningkatkan kesehatan fisik dan emosional. Terapi ini dianggap aman jika dilakukan oleh terapis yang terlatih dan berpengalaman, serta bermanfaat dalam berbagai tahapan reproduksi.

Deep Back Massage untuk Nyeri Persalinan adalah metode nonfarmakologis yang digunakan selama persalinan untuk membantu mengelola nyeri dan meningkatkan relaksasi. Pijat ini melibatkan penerapan tekanan yang kuat dan konsisten atau usapan yang lambat dan dalam pada punggung bawah dan area sakrum, yang mana merumakan titik sensasi nyeri yang intens selama persalinan. Pijat ini sering dilakukan oleh pasangan, doula, atau bidan dan bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kelegaan

dengan merangsang aliran darah, melepaskan endorfin, dan mengurangi ketegangan otot.

B. Anatomi Punggung dalam Terapi *Massage*

Nyeri persalinan terbagi dalam 2 fase yaitu, pada saat persalinan kala I (sejak awal kontraksi hingga pembukaan legkap) dan kala II (saat proses *crowning* kepala bayi hingga lahirnya seluruh produk kehamilan). Pada saat kontraksi selama proses kala I, Rangsangan nyeri dari dilatasi serviks masuk ke medula spinalis pada segmen T10, T 11, T12, dan L1. Sedangkan, Rangsangan nyeri dari distensi vagina dan perineum berjalan melalui saraf pudendal dan memasuki sumsum tulang belakang pada segmen S2, S3, dan S4

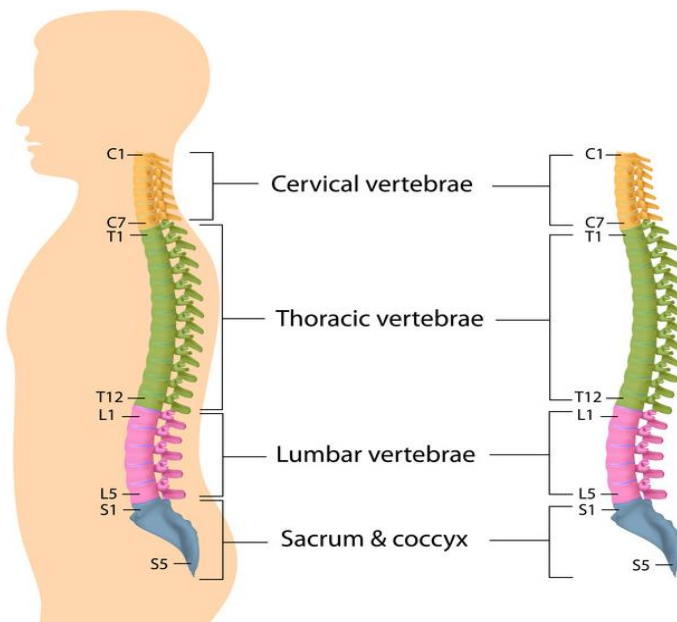


Gambar 4.1 Syaraf dalam nyeri persalinan

Tulang belakang terdiri dari rangkaian vertebra yang melindungi sumsum tulang belakang dan mendukung

tubuh. Bagian yang paling sering terlibat dalam nyeri persalinan meliputi:

1. Bagian Thoracic (T10-T12) dan Bagian Lumbar (L1). Syaraf-syaraf ini menyalurkan nyeri akibat adanya dilatasi servik dan juga kontraksi pada korpus uteri. Pada akhir kala satu syaraf dari T10 dan L1 juga terlibat, karena letaknya yang dekat dengan panggul.
2. Bagian Sacrum dan Coccyx. Sacrum adalah tulang berbentuk segitiga di pangkal tulang belakang yang terhubung ke panggul. Coccyx (tulang ekor) adalah ujung bawah tulang belakang dan sering tertekan selama proses persalinan. Area ini berperan penting dalam nyeri "*back labor*" yang terjadi saat kepala janin menekan punggung bawah.



Gambar 4.2 Tulang Belakang

Otot punggung berperan penting dalam mendukung tulang belakang dan membantu ibu selama proses persalinan. Beberapa otot utama yang terkait dengan nyeri persalinan adalah:

1. Trapezius:

- a. Terletak di punggung atas.
- b. Menegang saat ibu merasa stres atau cemas, sehingga meningkatkan ketidaknyamanan.

2. Latissimus Dorsi:

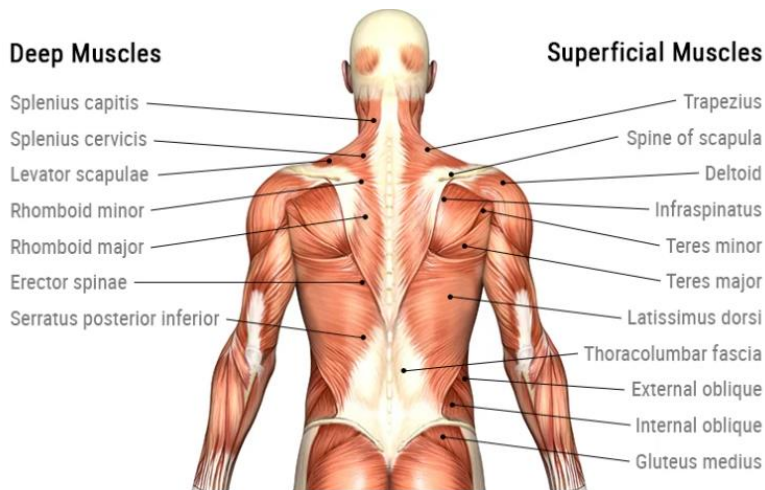
- a. Terletak di punggung tengah dan bawah.
- b. Berperan dalam membantu pergerakan tubuh selama proses persalinan.

3. Erector Spinae:

- a. Kelompok otot panjang di sepanjang tulang belakang.
- b. Sering mengalami ketegangan saat ibu mengatur posisi tubuh selama kontraksi.

4. Multifidus dan Rotatores:

- a. Otot kecil dan dalam yang menghubungkan vertebra.
- b. Penting untuk stabilitas tulang belakang tetapi dapat terasa nyeri akibat tekanan atau posisi janin yang tidak optimal.



Gambar 4.3 Otot Punggung

Pemahaman yang mendalam tentang anatomi tulang belakang dan otot punggung adalah kunci untuk memberikan pijatan yang aman, efektif, dan nyaman kepada ibu bersalin. Hal ini penting karena kondisi fisiologis dan anatomis ibu selama persalinan berbeda dari kondisi biasa, sehingga memerlukan perhatian khusus.

Pelaksanaan massage di mulai dari memberikan stimulasi pada otot Trapezius yang terletak pada punggung bagian atas, hal ini dilakukan untuk mengurangi perasaan stress, tegang, cemas dan lelah yang di rasakan oleh ibu pada saat awal persalinan. Kemudian di lanjutkan massage dengan teknik efflurage di sepanjang tulang belakang dan dilanjutkan dengan memberikan penekanan secara lembut pada *accupoint* sepanjang T10-L1. Setelah massage pada bagian punggung selesai, di lanjutkan pada daerah sacrum dengan melakukan *counterpressure* (penekanan dengan menggunakan bola tenis ataupun kepalan tangan pada

daerah Sacrum) ini merupakan pusat nyeri pada saat persalinan atau sering di sebut dengan "*back labor*".

C. Manfaat *Deep Back Massage* pada Persalinan

Deep Back Massage adalah salah satu metode pijat yang efektif untuk meredakan ketegangan otot kronis. Teknik ini dilakukan dengan memberikan tekanan mendalam dan lambat pada otot yang tegang, mengikuti arah serabut otot, tendon, dan fasia. Terapi ini bekerja pada lapisan otot yang lebih dalam dan sangat berguna untuk mengurangi ketegangan otot.

Manfaat dari Deep Back Massage meliputi:

1. Mengurangi Stres, Kecemasan, dan Ketegangan Otot

Stres kronis dan ketegangan otot dapat berdampak negatif pada kesehatan, memperlambat proses pemulihan, menurunkan fungsi sistem imun, dan meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi. Deep Back Massage terbukti mampu menurunkan kadar kortisol sekaligus meningkatkan produksi hormon oksitosin, yang membantu tubuh rileks dan memberikan efek menenangkan.

2. Mengatasi Nyeri Kronis

Penelitian yang diterbitkan dalam *Scientific World Journal* menunjukkan bahwa Deep Back Massage memberikan efek positif yang setara dengan pijat biasa atau penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) dalam mengurangi rasa nyeri pada pasien dengan kondisi kronis

3. Menurunkan Tekanan Darah

Studi yang dimuat dalam *Journal of Alternative and Complementary Medicine* menemukan bahwa sesi Deep

Back Massage selama 45 hingga 60 menit dapat membantu menurunkan tekanan darah secara signifikan

4. Meningkatkan pelaksanaan asuhan dengan prinsip *Woman-Centered Care*

Pemberian massage selama persalinan merupakan salah satu bentuk pendampingan kepada ibu selama persalinan. Pendekatan ini dalam pemberian pelayanan kebidanan merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan, nilai, dan preferensi wanita sebagai pusat perhatian. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang holistik, menghormati otonomi wanita, serta memastikan bahwa pengalaman kesehatan reproduksi dan persalinan mereka menjadi positif.

5. Meningkatkan pengalaman positif dalam persalinan

Massage selama persalinan memberikan manfaat holistik yang mencakup pengelolaan nyeri, peningkatan relaksasi, dan dukungan emosional, sehingga membantu ibu menghadapi persalinan dengan lebih percaya diri dan nyaman. Pengalaman positif ini berkontribusi pada persepsi ibu tentang persalinan sebagai momen yang memberdayakan dan memuaskan.

6. Meningkatkan kepuasan dalam asuhan

Massage selama persalinan menawarkan manfaat multifaset yang mendukung kenyamanan fisik, emosional, dan psikologis pasien. Dengan mengurangi rasa sakit, menciptakan relaksasi, dan meningkatkan dukungan emosional, massage membantu menjadikan persalinan sebagai pengalaman yang lebih memuaskan dan memberdayakan. Hal ini mencerminkan bagaimana layanan yang di berikan selama persalinan memenuhi harapan ibu dan keluarga. Kepuasan layanan yang di berikan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan

instansi pelayanan kesehatan dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pasien.

7. Mencegah partus lama

Massage selama persalinan bekerja melalui mekanisme fisik dan hormonal untuk meningkatkan efisiensi kontraksi, mengurangi nyeri, dan menciptakan kondisi yang mendukung progres persalinan. Dengan mengurangi stres, ketegangan, dan ketidakefisienan kontraksi, massage membantu mencegah terjadinya partus lama, mendukung proses persalinan yang lebih cepat dan aman.

8. Pemberian massage selama persalinan mampu mempengaruhi APGAR score bayi saat lahir

Massage selama persalinan memberikan manfaat bagi ibu dan janin dengan menciptakan kondisi optimal untuk persalinan. Dengan meningkatkan sirkulasi, mengurangi stres, dan mendukung proses persalinan yang efisien, massage membantu mencegah komplikasi yang dapat memengaruhi skor APGAR bayi. Hasilnya, bayi lebih mungkin lahir dalam kondisi sehat dengan pernapasan, detak jantung, tonus otot, dan warna kulit yang baik.

D. Teknik Dasar *Deep Back Massage*

Beberapa hal dasar yang perlu diperhatikan saat melakukan massage, diantaranya:

1. Penekanan dan Irama Gerakan Pemijatan

Ketenangan orang yang dipijat dapat dicapai melalui gerakan pengurutan yang halus, ringan, perlahan, dan berirama.

2. Frekuensi Pengurutan

Frekuensi gerakan pengurutan, terutama pada area sensitif, disesuaikan dengan kondisi kulit, usia, dan tujuan perawatan.

3. Arah Pengurutan

Semua gerakan pengurutan dilakukan tegak lurus terhadap lipatan kulit atau sejajar dengan arah serat-serat otot.

Massage adalah kombinasi berbagai gerakan yang digunakan untuk memanipulasi jaringan untuk mendapatkan efek dan manfaat lokal maupun menyeluruh. Gerakan berkisar dari usapan lembut hingga gesekan yang menyegarkan, tergantung pada efek yang diinginkan. Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melakukan massage diantaranya:

1. *Effleurage*

Cara melakukan teknik massage efflurage:

- a. Terapis perlu berada dalam posisi yang stabil untuk menjaga kenyamanan dan keseimbangan selama proses pijatan.
- b. Effleurage merupakan teknik pijatan lembut berupa gerakan membelai yang menenangkan, biasanya dilakukan menggunakan telapak salah satu atau kedua tangan.
- c. Posisi tangan harus rileks, dengan jari-jari saling menempel dan disesuaikan dengan bentuk area tubuh yang dipijat.
- d. Gerakan dilakukan searah dengan aliran darah menuju jantung, kecuali dalam teknik effleurage terbalik.
- e. Kontak tangan dengan kulit tetap dipertahankan selama gerakan kembali, meskipun tekanan yang

diberikan lebih ringan dibandingkan saat memijat ke depan.

- f. Tekanan dalam teknik effleurage dapat bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga kuat/dalam, tergantung pada kebutuhan dan tujuan pijatan. Namun, tekanan secara bertahap meningkat di akhir gerakan untuk memberikan efek maksimal.



Gambar 4.4 Effleurage

2. *Petrissage/Kneading* atau memijit/meremas.

- a. Definisi Petrissage: Petrissage adalah teknik pijatan berupa gerakan kompresi atau remasan yang bertujuan untuk meredakan ketegangan otot.
- b. Variasi Gerakan: Gerakan dapat dilakukan menggunakan satu tangan, dua tangan, atau dengan

Asuhan Kebidanan Persalinan: Intervensi Deep Back Massage
Menggunakan Frangipani Essensial Oil Terhadap Penurunan Nyeri
Persalinan Kala 1 Fase Aktif

jari, tergantung pada area yang dipijat dan kebutuhan penerima.

- c. Arah Tekanan: Tekanan selalu diarahkan ke atas, mengikuti aliran darah menuju jantung untuk membantu meningkatkan sirkulasi.
- d. Karakteristik Gerakan: Semua gerakan dilakukan dengan tegas dan bertujuan untuk merangsang otot serta jaringan yang dipijat.
- e. Kecepatan Gerakan: Gerakan dapat dilakukan dengan ritme cepat untuk efek stimulasi atau perlahan untuk memberikan relaksasi yang lebih dalam. Jika dilakukan secara perlahan, teknik ini membantu melemaskan struktur otot dasar yang sedang dirawat.



Gambar 4.5 *Petrissage/Kneading*

3. *Friction*

- a. Tujuan Utama: Pijatan dilakukan dengan memberikan tekanan mendalam, bertujuan menghilangkan dan melepaskan ketegangan pada area lokal tertentu.
- b. Alat yang Digunakan: Gerakan dilakukan menggunakan bantalan jari atau ibu jari, namun dalam beberapa kasus, tumit tangan, buku jari, atau siku juga dapat digunakan untuk memberikan tekanan yang lebih dalam.
- c. Efektivitas Gerakan: Gerakan ini harus memengaruhi tidak hanya kulit, tetapi juga jaringan otot di bawahnya, memastikan efek yang lebih mendalam.
- d. Persiapan Area: Gesekan sebaiknya dilakukan setelah area yang akan dipijat cukup dihangatkan menggunakan teknik effleurage dan petrissage untuk mencegah cedera atau ketidaknyamanan.
- e. Teknik Tekanan: Tekanan diberikan secara bertahap, dimulai dari intensitas ringan hingga dalam, dan dilepaskan perlahan untuk memastikan kenyamanan penerima.



Gambar 4.6 *Friction*

4. Pressure

- a. Metode pijatan yang memberikan tekanan berlawanan pada area tertentu di tubuh ibu selama persalinan. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit, terutama nyeri punggung, yang sering terjadi akibat tekanan dari kepala janin pada tulang belakang ibu (back labor).
- b. Terapis disarankan untuk memulai dengan gerakan ringan dan tekanan lembut, kemudian secara bertahap meningkatkan intensitas gerakan dan tekanan sesuai kebutuhan. Sepanjang sesi, terapis perlu berdiskusi dengan klien untuk memahami preferensi mereka.
- c. Teknik Penekanan: Terapis atau pendamping persalinan menggunakan telapak tangan, kepala tangan, atau siku untuk memberikan tekanan langsung pada area nyeri. Tekanan harus stabil, kuat, dan diarahkan ke tulang sakrum atau titik nyeri yang sesuai. Kombinasikan dengan gerakan melingkar atau dorongan ritmis jika diperlukan.



Gambar 4.7 Pressure

E. Posis Ibu Bersalin saat melakukan *Deep Back Massage*

Posisi ibu bersalin saat dilakukan massage bertujuan untuk memberikan kenyamanan, mengurangi rasa nyeri, dan memfasilitasi proses persalinan. Berikut adalah beberapa posisi yang biasa digunakan:

1. *Sidelying positioning*. Pada posisi ini ibu dianjurkan miring ke kiri gunakan cukup bantal untuk menyangga kepala dan leher. Tambahkan bantal untuk menyangga sendi panggul. Posisi lutut satu garis dengan kepala dan *trochanter*. *Sudut sendi* panggul yang dibentuk kurang lebih 90 derajat. Selain itu berikan bantal pada lengan ibu.



Gambar 4.4 Sidelying positioning (1)



Gambar 4.5 Sidelying positioning (2)

2. *Seated Position*. Posisi ini merupakan salah satu posisi yang sering digunakan untuk massage pada ibu hamil/bersalin karena memberikan kenyamanan sekaligus akses mudah ke area tubuh tertentu, seperti punggung, bahu, dan leher.



Gambar 4.6 *Seated Position* (1)



Gambar 4.7 *Seated Position* (2)

F. Langkah-langkah pelaksanaan *Deep Back Massage* pada Persalinan

Tabel 4.1 Langkah-langkah pelaksanaan Deep Back Masage pada Persalinan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DEEP BACK MESSAGE UNTUK NYERI PERSALINAN	
PENGERTIAN	Massage effleurage ini merupakan metode pemijatan dengan memberikan usapan lembut dengan sedikit memberi tekanan dengan menggunakan telapak tangan yang lambat dan panjang serta tidak putus-putus pada bagian bahu, punggung, pinggang sehingga akan memberikan efek relaksasi dan nyeri akan berkurang (Potter & Perry, 2010).
TUJUAN PROSEDUR	1. Melancarkan sirkulasi darah 2. Menurunkan respon nyeri punggung. 3. Menurunkan ketegangan otot
INDIKASI PROSEDUR	Ibu dalam masa inpartu dengan gangguan rasa nyaman nyeri punggung
KONTRA INDIKASI PROSEDUR	1. Nyeri pada daerah yang akan di massage 2. Luka pada daerah yang akan di massage 3. Gangguan atau penyakit kulit 4. Jangan melakukan pemijatan pada ibu yang memiliki tumor 5. Jangan melakukan masase pada daerah yang mengalami ekimosis atau lebam 6. Hindari melakukan massage pada daerah yang mengalami inflamasi 7. Jangan melakukan massage pada daerah yang mengalami tromboplebitis 8. Hati-hati saat melakukan masase pada daerah yang mengalami gangguan sensasi seperti penurunan sensasi maupun hiperanastesia

PERSIAPAN ALAT	1. Kemben/Jarik 2. Lavender oil sebagai "Moisteners" 3. Mangkuk kecil 4. Handuk 5. Baskom air hangat 6. Bantal 7. Ruangan yang nyaman
PROSEDUR PELAKSANAAN	A. Persiapan 1. Mencuci tangan sebelum tindakan 2. Memberikan salam dan memperkenalkan diri 3. Menjelaskan maksud dan tujuan 4. Meminta persetujuan klien dengan menggunakan informed consent 5. Menjelaskan prosedur atau tindakan yang akan dilakukan 6. Menanyakan kesiapan klien 7. Menjaga privasi klien 8. Persiapkan perlengkapan yang akan digunakan B. Pelaksanaan 1. Beri tahu klien bahwa tindakan akan segera dimulai. 2. Cuci tangan. 3. Periksa vital sign klien sebelum memulai Deep Back Massage. 4. Posisikan klien dengan posisi miring ke kiri atau duduk untuk mencegah terjadinya hipoksia janin 5. Instruksikan klien untuk menarik nafas dalam melalui hidung dan mengeluarkan lewat mulut secara perlahan sampai klien merasa rileks.

-
6. Tuangkan baby oil pada telapak tangan kemudian gosokan kedua tangan hingga hangat.

C. Teknik Pemijatan

1. Upper back and shoulder massage

Pemijatan pada bagian ini akan memperbaiki Teknik pernafasan ibu kan menurunkan ketegangan di area leher-pundak.

- Letakkan tangan pada Pundak, Kemudian lakukan pemijatan dengan cara mengurut (efflurage) menggunakan jempol tangan dari arah leher → Pundak → leher.

Shoulders



- Letakkan tangan pada Pundak, dengan ibu jari tepat di belakang tulang belikat dan lakukan pemijatan dengan memberikan sedikit penekanan dalam bentuk spiral atau melingkar.



-
- Letakkan telapak tangan di sekitar tulang belikat dan lakukan Gerakan mengurut (efflurage) pada sekitar tulang belikat

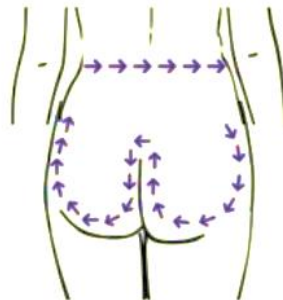
Upper Back



2. Lower back circular massage

- Sembari meminta ibu untuk menarik nafas dalam, lakukan pengurutan (efflurage) di daerah pinggang di mulai dari pinggul sebelah kiri ke kanan. Kemudian minta ibu menghembuskan nafas sembari melanjutkan pemijatan pada daerah pantat ibu dengan arah sesuai yang ada pada gambar → Teknik ini sering digunakan pada saat kontraksi muncul

lower back circular massage



3. Sacral pressure

-
- Letakkan tangan kiri pada bahu ibu ataupun pinggang ibu dan tangan kanan pada daerah sacrum. Pijat menggunakan kepala tangan atau tapak tangan, pemijatan dilakukan searah dengan jarum jam

Sacrum



4. Whole back massage

- Secara perlahan dan lembut, lakukan pemijatan mulai dari bahu, gerakkan tangan Anda ke bawah pada bagian luar punggung dan ke tengah, jaga kedua tangan di kedua sisi tulang belakang

Back & Buttocks



5. Buttocks and hips

- Lakukan pemijatan melingkar dimulai dari titik sacrum ke arah luar bokong. Pemijatan
-

dilakukan menggunakan pangkal tapak tangan

- Hip kneading → lakukan pemijatan dengan melakukan penekanan dengan arah melingkar pada daerah panggul



EVALUASI	1. Evaluasi yang dicapai (penurunan skala nyeri) 2. Beri reinforcement positif pada ibu hamil 3. Mengakhiri pertemuan dengan baik
DOKUMENTASI	1. Tanggal atau jam dilakukan tindakan 2. Nama tindakan 3. Respon klien selama tindakan 4. Nama dan paraf bidan
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN	1. Hindari pelaksanaan massage apabila klien dalam keadaan kenyang/lapar 2. Kenyamanan dan kekuatan kondisi fisik klien harus selalu dikaji untuk mengetahui keadaan klien selama prosedur 3. Istirahatkan klien terlebih dahulu setelah dilakukan masase punggung selama kurang lebih 1-2 menit 4. Perhatikan kontraindikasi dilakukan tindakan

G. Kontraindikasi *Deep Back Massage* pada Persalinan

Massage atau pijat pada ibu bersalin dapat memberikan manfaat, seperti meningkatkan relaksasi, mengurangi nyeri, dan membantu memperlancar proses persalinan. Namun, terdapat beberapa kondisi yang menjadi kontraindikasi untuk pelaksanaannya, yaitu:

Tabel 4.2 Kontradiksi *Deep Back Massage* pada persalinan

Ibu hamil/bersalin yang mengalami gangguan <i>cardiovascular</i>	
<i>Angina Pectoral</i>	Kondisi kurangnya pasokan darah ke jantung, menyebabkan kejang dan nyeri di area dada
<i>Arrhythmia</i>	Detak jantung abnormal / tidak teratur
<i>Haematoma</i>	memar di dalam jaringan lunak, biasanya otot. Sering kali disebabkan oleh cedera. Gejalanya sering kali akan hilang seiring waktu, tetapi butuh waktu beberapa bulan sebelum semua memar dan bengkak hilang.
<i>Haemophilia</i>	Suatu kondisi berkurangnya atau tidak adanya zat yang membantu pembekuan darah.
<i>Hypertension</i>	Tekanan darah tinggi secara klinis
<i>Hypotension</i>	Tekanan darah rendah secara klinis
<i>Oedema</i>	Edema adalah penumpukan cairan limfa yang berlebihan di dalam tubuh, edema adalah peningkatan cairan interstisial di organ, jaringan, atau rongga mana pun.

<i>Phlebitis</i>	Suatu kondisi ketika lapisan vena di kaki mengalami peradangan dan dapat mengakibatkan trombosis.
<i>Thrombosis</i>	Gumpalan darah yang terbentuk pada dinding vena, biasanya di kaki.
Ibu hamil/ bersalin yang mengalami gangguan <i>Digestive</i>	
<i>Gastric (stomach) ulcer</i>	Luka terbuka yang berkembang pada lapisan lambung.
<i>Vomiting and diarrhoea</i>	Muntah dan diare menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Biasanya, ini merupakan tanda infeksi.
Ibu hamil/ bersalin yang mengalami gangguan <i>Endocrine</i>	
<i>Diabetes</i>	Sekelompok gangguan metabolisme yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah dalam jangka waktu lama.
Ibu hamil/ bersalin yang mengalami gangguan <i>Immune</i>	
<i>HIV/AIDS</i>	HIV adalah virus yang merusak sel-sel dalam sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan untuk melawan infeksi dan penyakit sehari-hari. AIDS Kerusakan sistem kekebalan tubuh membuat penerima rentan terhadap patogen apa pun.
Ibu hamil/ bersalin yang mengalami gangguan <i>Infectious Disease</i>	
<i>Infections</i>	Herpes simplex, Scabies, Ringworm, Tuberculosis, Hepatitis, Influenza.
<i>Fever</i>	Demam adalah peningkatan suhu tubuh di atas (37,8°C). Demam

	umumnya terjadi sebagai respons terhadap infeksi dan merupakan respons sistem kekebalan tubuh yang penting.
<i>Meningitis</i>	Peradangan pada jaringan ikat (Meninges) yang melingkari tulang belakang dan otak.
Ibu hamil/ bersalin yang mengalami gangguan <i>Musculo-skeletal</i>	
<i>Ankylosing Spondylitis</i>	Peradangan kronis pada tulang belakang dan sendi sakroiliaka.
<i>Hernia</i>	Hernia terjadi ketika bagian dalam tubuh, seperti organ, mendorong keluar melalui kelemahan pada otot atau dinding jaringan di sekitarnya.
<i>Muscular spasticity</i>	Spastisitas adalah kondisi di mana otot menegang atau mengencang, sehingga mencegah pergerakan cairan normal. Otot tetap berkontraksi dan menolak untuk diregangkan, sehingga memengaruhi gerakan, bicara, dan cara berjalan.
<i>Osteoporosis</i>	Kondisi di mana tulang menjadi tipis dan lemah serta mudah patah. Tulang mulai kehilangan kepadatan, terutama kalsium dan kolagen.
<i>Spinal Deformities</i>	Kelainan bentuk vertebrae yang melengkung dari satu sisi ke sisi lain disebut skoliosis; lengkung ke depan (kifosis) menggeser pusat keseimbangan ke depan panggul;

	punggung bawah yang cekung (lordosis) mendorong panggul ke depan.
Ibu hamil/ bersalin yang mengalami gangguan <i>Nervous system</i>	
<i>Bell's palsy</i>	Kelumpuhan otot-otot wajah yang disebabkan oleh infeksi, akibat stroke atau cedera tengkorak.
<i>Epilepsy</i>	Epilepsi merupakan kondisi umum di mana lonjakan aktivitas listrik secara tiba-tiba dalam otak menyebabkan kejang atau ayun.
<i>Neuritis</i>	Peradangan saraf.
<i>Psychosis</i>	Psikosis adalah kondisi pikiran yang menyebabkan kesulitan menentukan apa yang nyata dan apa yang tidak nyata. Gejalanya dapat berupa delusi dan halusinasi.
Ibu hamil/ bersalin yang mengalami gangguan <i>Respiratory</i>	
<i>Asthma</i>	Asma adalah kondisi jangka panjang di mana saluran napas yang terlalu sensitif menjadi sempit dan meradang, sehingga menyulitkan untuk bernapas masuk dan keluar secara normal.
Ibu hamil/ bersalin yang mengalami gangguan pada kulit	
<i>Disorders affecting the treatment area</i>	<i>Severe eczema, psoriasis, dermatitis, allergy reactions, active alopecia, acne vulgaris, acne rosacea.</i>

<i>Scar tissue</i>	Bekas luka adalah area jaringan fibrosa yang menggantikan kulit normal setelah cedera.
Ibu hamil/ bersalin yang dalam status resiko tinggi	
Preeklampsia eklampsia	- Tekanan darah tinggi pada ibu bersalin / kejang hal ini dapat memperparah kondisi jika dilakukan <i>massage</i>
Plasenta previa	Letak placenta menutupi jalan lahir, <i>massage</i> dapat meningkatkan risiko perdarahan
Riwayat perdarahan	<i>Massage</i> dapat meningkatkan risiko perdarahan
Kehamilan ganda	Kehamilan dengan 2 janin atau lebih
Oligohidramnion	Kondisi medis dalam kehamilan yang ditandai oleh jumlah cairan ketuban yang lebih rendah dari normal.
Polihidramnion	Kondisi medis dalam kehamilan yang ditandai oleh jumlah cairan ketuban yang lebih banyak dari normal.
Malpresentasi janin	Kondisi di mana posisi atau letak janin di dalam rahim tidak normal menjelang persalinan.

BAB 5

FRANGIPANGI ESSENTIAL OIL

A. Definisi dan Sumber *Frangipangi Essential Oil*

Essential oil adalah ekstrak yang sangat terkonsentrasi yang berasal dari berbagai bagian tanaman seperti bunga, daun, batang, dan akar. Minyak ini mengandung aroma khas dan khasiat terapeutik dari tanaman asalnya. Minyak ini dapat digunakan dalam berbagai cara, termasuk dihirup, dioleskan, dan ditelan (meskipun penggunaan internal hanya boleh dilakukan di bawah bimbingan seorang profesional yang berkualifikasi).



Gambar 5.1 *Frangipangi Essential Oil*

Frangipani atau kamboja memiliki nama latin *Plumeria rubra*, termasuk dalam famili *Apocynaceae*. Salah satu bunga yang umum tumbuh di Indonesia khususnya Bali dan Jawa. Frangipani mudah untuk tumbuh di daerah tropis dan menyimpan air di akar, daun, bunga dan batang pohon. *Frangipani essential oil* telah digunakan selama bertahun-tahun dalam pengobatan tradisional karena mempunyai berbagai manfaat.

Minyak esensial kamboja diekstrak dari bunga kamboja, yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Minyak ini diekstrak melalui proses penyulingan uap, yang melibatkan pemanasan bunga untuk melepaskan minyak alaminya. Dikenal karena aromanya yang harum. Selain aromanya yang menyenangkan, minyak esensial kamboja juga dikenal karena khasiat terapeutiknya. Minyak ini umumnya digunakan dalam aromaterapi untuk meningkatkan relaksasi dan mengurangi tingkat stress.



Gambar 5.2 Pohon Kamboja

Produksi lulur tubuh, masker wajah dan minyak pijat dijadikan pemanfaatan frangipani dalam bidang estetika. Aroma dari bunga frangipani dapat memberikan efek mengurangi kelelahan psikologis dan kelelahan fisik pada manusia.

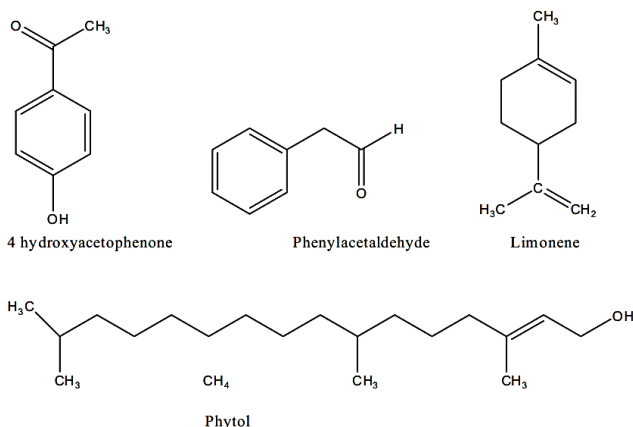
B. Komposisi *Frangipangi Essential Oil*

Pada frangipani terdapat senyawa volatile yang menyebabkan bunga memiliki bau harum sehingga banyak digunakan sebagai campuran parfum, kosmetik dan aromaterapi. Komponen utama minyak esensial kamboja adalah eugenol, linalool, benzyl asetat, dan geraniol. Bunga

Asuhan Kebidanan Persalinan: Intervensi Deep Back Massage
Menggunakan Frangipani Essensial Oil Terhadap Penurunan Nyeri
Persalinan Kala 1 Fase Aktif

kamboja mengandung senyawa aktif berupa triterpenoid dan amyrin yang dapat berperan sebagai relaksan dan mengurangi rasa nyeri.

Bunga kamboja berbau harum dan segar, aromanya diterima oleh reseptor hidung yang kemudian mengirimkan sinyal ke otak di area pengaturan emosi dan memori, yang kemudian memberikan sinyal ke hipotalamus sebagai pengatur stres. Aroma bunga kamboja dihasilkan dari senyawa esensial yaitu geraniol, citronellol, dan linalool.



Gambar 5.3 Struktur kimia senyawa frangipani

Minyak bunga kamboja yang dioleskan pada kulit akan berikatan dengan golongan steroid kelenjar keringat yang disebut osmon. Golongan steroid ini akan merangsang thalamus untuk memproduksi enkephalin sebagai penghilang rasa nyeri alami dan memberikan sensasi aman. Ketika seorang perempuan merasa rileks, maka akan diproduksi hormon endorfin sebagai hormon alami yang dapat meningkatkan suasana hati dan pikiran. Serta menjadi obat penenang sehingga rasa nyeri berkurang.

Frangipani essential oil juga memiliki khasiat anti-radang dan analgesik, yang membuatnya bermanfaat untuk

mengobati berbagai kondisi, termasuk radang sendi, nyeri otot, dan sakit kepala. Digunakan juga dalam produk perawatan kulit, karena memiliki sifat melembabkan dan anti-penuaan yang dapat membantu memperbaiki penampilan kulit. Serta digunakan dalam perawatan rambut karena sifat regeneratifnya yang kuat.

Memiliki sifat anti-mikroba yang dapat membantu melawan bakteri dan virus berbahaya. Minyak ini dapat digunakan untuk mengobati luka kecil, goresan, dan gigitan serangga, membantu mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan. Memiliki sifat regeneratif yang kuat yang membantu menyembuhkan luka dan mengurangi jaringan parut.

C. Manfaat *Frangipani Essential Oil* dalam Manajemen Nyeri Persalinan

Massage dan aromaterapi menggunakan *frangipani essential oil* memberikan manfaat secara fisiologis dan psikologis. Secara fisiologis, impuls nyeri dapat diatur atau dihambat oleh mekanisme pertahanan sistem saraf pusat sesuai dengan teori gate control. Secara psikologis aromaterapi frangipani dapat meningkatkan rasa nyaman dan relaksasi karena meredakan ketegangan dan kecemasan.

Pemijatan dengan minyak kamboja akan menyebabkan minyak terserap oleh tubuh melalui folikel rambut dan kelenjar keringat. Minyak ini memiliki khasiat analgesik dengan menghambat enzim siklooksigenase dan atau lipoksigenase, yang dapat menurunkan indeks nyeri dari nyeri hebat menjadi nyeri sedang.

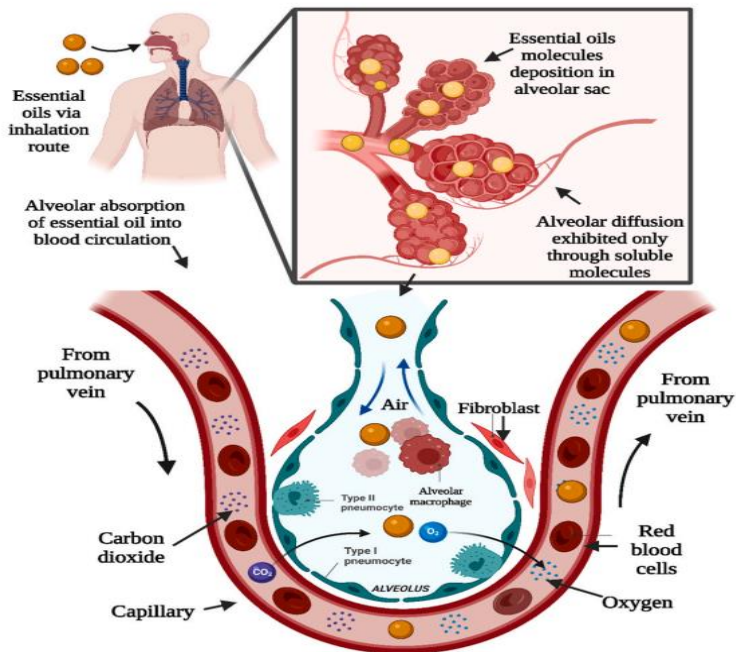


Gambar 5.4 Penggunaan *Frangipani essential oil*

Pemanfaatan minyak aromaterapi bunga kamboja mampu menurunkan tingkat intensitas nyeri saat persalinan. Hal ini berarti intensitas nyeri saat persalinan dapat dikurangi melalui strategi sederhana dengan memanfaatkan sumber daya alam setempat. Metode ini dapat menjadi alternatif cara non-farmakologis untuk mengurangi nyeri yang dialami ibu saat persalinan.

Selain itu, aromaterapi juga merangsang thalamus untuk mengeluarkan enkephalin yang berfungsi sebagai penghilang rasa nyeri alami. Proses penyerapan minyak atsiri melalui alveolus ke dalam sirkulasi darah yaitu dimulai dari menghirup minyak atsiri sehingga molekul-molekul ini masuk ke kantung alveolus sistem pernapasan. Hanya molekul terlarut yang menunjukkan difusi alveolus untuk

bercampur ke dalam aliran darah dan selanjutnya bersirkulasi ke dalam tubuh.



Gambar 5.4 Mekanisme inhalasi *Frangipani essential oil*

Ibu yang diberikan pijat dan diberikan aromaterapi *frangipani essential oil* menjadi lebih tenang dalam menghadapi persalinan, sehingga persalinan yang lama dapat dicegah. Pemanfaatan minyak atsiri bunga kamboja untuk perbaikan fisik dan emosional telah dilakukan sebagai metode pelengkap dalam praktik kebidanan. Namun, aromaterapi *frangipani essential oil* masih sangat jarang digunakan sebagai terapi alternatif untuk mengurangi nyeri persalinan karena belum dipopulerkan dalam praktik kebidanan.

D. Keamanan dan Kontraindikasi penggunaan *Frangipangi Essential Oil*

Cara untuk memastikan keamanan pemakaian *frangipani essential oil* dapat dilakukan dengan:

1. Pengenceran

Sebelum menggunakan *essential oil* selalu encerkan dengan minyak pembawa sebelum dioleskan ke kulit. Minyak atsiri memerlukan proses pengenceran untuk mencegah efek samping. Jaga konsentrasi minyak esensial di bawah 5%. Pengenceran 1 persen setara dengan menambahkan 6 tetes minyak esensial ke dalam 1 ons minyak pembawa.

Namun, pedoman konsentrasi minyak atsiri yang aman bervariasi tergantung pada usia dan status kesehatan. Minyak pembawa biasanya berbahan dasar tumbuhan, sehingga minyak esensial yang aman dioleskan pada kulit dapat dengan mudah diencerkan dengan minyak pembawa.

2. Uji Tempel, lakukan tes kecil pada kulit untuk memastikan tidak mengalami reaksi alergi. Tujuan dari uji tempel adalah untuk melihat bagaimana kulit bereaksi terhadap minyak esensial kamboja sebelum mengaplikasikannya ke seluruh tubuh. Untuk melakukan uji tempel, pertamanya cuci lengan dengan sabun tanpa pewangi dan biarkan kering. Oleskan beberapa tetes minyak esensial kamboja ke lengan.

Jika kulit mengalami bintik-bintik merah, gatal, melepuh, atau bengkak, mungkin mengalami reaksi negatif terhadap minyak esensial kamboja dan sebaiknya hentikan penggunaannya. Segera cuci area tersebut dengan sabun dan air hangat untuk menghilangkan setiap tetes minyak esensial kamboja.

3. Hindari Area Sensitif, jangan oleskan *frangipani essential oil* di dekat mata, telinga, atau area sensitif lainnya.
4. Konsultasikan dengan Profesional, jika memiliki kondisi medis atau sedang mengonsumsi obat tertentu, konsultasikan dengan profesional kesehatan sebelum menggunakan minyak esensial.

Meskipun secara umum pemakaian *frangipani essential oil* dianggap aman, ada beberapa kontraindikasi yang harus diperhatikan untuk memastikan penggunaannya yang aman dan efektif. Berbagai jenis kontraindikasi, meliputi:

1. Alergi, beberapa orang mungkin memiliki alergi atau kepekaan terhadap *frangipani essential oil*. Penting untuk mengetahui adanya alergi yang diketahui sebelum menggunakannya. Disarankan untuk melakukan uji tempel sebelum mengoleskan *frangipani essential oil* pada kulit.



Gambar 5.6 Ruam Pada kulit akibat alergi

2. Kondisi Kulit, kondisi kulit tertentu dapat diperburuk oleh penggunaan minyak esensial tertentu. Misalnya, orang dengan eksem atau psoriasis mungkin menemukan bahwa minyak tertentu mengiritasi kulit mereka atau memicu kambuhnya penyakit. Penting untuk berkonsultasi dengan profesional perawatan kesehatan atau aromaterapis berpengalaman sebelum menggunakan *frangipani essential oil*.

3. Kondisi Pernapasan, orang dengan kondisi pernapasan seperti asma atau bronkitis kronis dapat mengalami gejala yang lebih parah saat terpapar aroma yang kuat dari minyak esensial.

E. Langkah-Langkah Penggunaan *Frangipangi Essential Oil* Dalam Manajemen Nyeri Persalinan

Saat menggunakan *frangipani essential oil*, penting untuk mengencerkannya sebelum mengoleskannya ke kulit. Hal ini membantu mencegah iritasi dan sensitivitas kulit. Minyak dapat diencerkan dengan minyak pembawa seperti minyak kelapa, minyak almond, atau minyak jojoba.

Langkah awal siapkan klien, dengan memberikan penjelasan pada klien tentang apa yang akan dilakukan padanya, manfaat, tujuan diberikannya *frangipani essential oil*.

Siapkan alat dan bahan, meliputi:

1. *Frangipani essential oil*
2. Timer
3. Lembar Observasi
4. Air
5. Diffuser
6. Handuk kecil
7. Baskom air hangat
8. Kursi atau Gym Ball
9. Ruang yang nyaman dan tertutup

Langkah-langkah penggunaan *frangipani essential oil* dalam manajemen nyeri persalinan (Massage dan Inhalasi), yaitu:

1. Lakukan cuci tangan
2. Siapkan difusser dan isi dengan air sampai batas yang ada di alat diffuser

3. Teteskan 3 tetes *frangipani essensial oil* ke dalam difusser
4. Letakkan difusser dimeja atau tempat lain dekat dengan klien dengan jarak $\pm$ 1 meter dari difusser
5. Hidupkan difusser
6. Anjurkan klien untuk tetap rileks dan menghirup wangi aroma terapi frangipani selama 20 menit
7. Jika sudah matikan diffuser
8. Atur posisi klien senyaman mungkin
9. Ukur skor nyeri klien sebelum diberikan *frangipani essensial oil*
10. Tuangkan *frangipani essensial oil* ke telapak tangan
11. Lakukan massase selama 20 menit
12. Ulangi 3x massage
13. Ukur skor nyeri klien setelah diberikan *frangipani essensial oil*
14. Bereskan alat



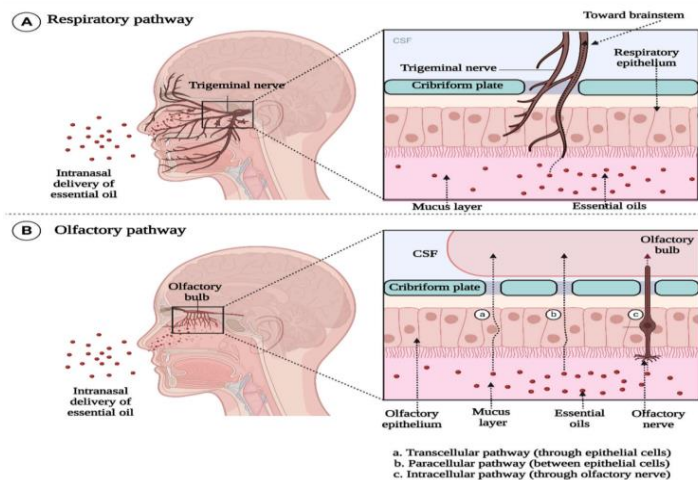
Gambar 5.7 Diffuser Aromaterapi

F. Mekanisme/Cara Kerja *Essential Oil* dalam Aromaterapi

Mekanisme kerja minyak esensial dalam aromaterapi meliputi peningkatan neurogenesis, pengaturan kadar hormon, stimulasi selektif pada beberapa daerah otak, perubahan biokimia darah yang memengaruhi suasana hati dan emosi adalah beberapa hasil yang dapat dipicu oleh potensi penggunaan minyak esensial. Hasil yang menguntungkan tersebut dihasilkan dari menghirup unsur-unsur volatil yang terkandung dalam minyak tersebut. Ketika dihirup, mekanisme kerja terdiri dari dua jalur stimulasi penciuman dan stimulasi pernapasan.

Aromaterapi inhalasi melalui stimulasi penciuman terutama bekerja melalui aktivasi saraf penciuman yang memanjang dari hidung menuju otak. Stimulasi terapeutik disebabkan oleh kemiripan strukturalnya yang dekat dengan neurotransmitter dan hormon fisiologis. Kimia struktural yang dekat tersebut menstimulasi kemoreseptor penciuman yang melapisi saluran hidung, sehingga mengaktifkan sinyal penciuman. Sinyal ini berakhir di korteks serebral bagian atas, yang kemudian diikuti oleh neuron sensori olfaktorius yang menyalurkan impuls listrik ke daerah limbik dan hipotalamus otak melalui bulbus olfaktorius dan korteks olfaktorius bagian atas.

Beberapa molekul yang sangat mudah menguap dapat langsung masuk ke otak dan mengatur jalur saraf saat terhirup dan dapat melewati seluruh sinyal olfaktorius. Hasil fisiologis akhirnya adalah lonjakan neurotransmitter dan neuromodulator, yang menyebabkan rasa tenang yang luar biasa dalam pikiran dan tubuh, sehingga meredakan gejala kecemasan dan depresi.



Gambar 5.8 Mekanisme/Cara Kerja Essential Oil dalam Aromaterapi

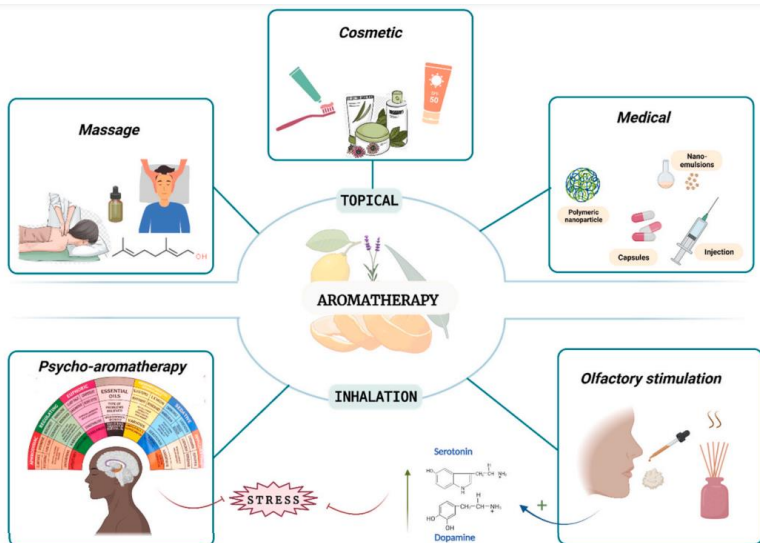
Selain stimulasi penciuman, jalur utama yang diambil oleh essential oil untuk mengubah fungsi otak adalah melalui penyerapan alveolar. Hal ini memungkinkan molekul essential oil memasuki sirkulasi darah, sehingga berpotensi berinteraksi dengan daerah otak. Pertukaran gas terjadi melalui sistem pernapasan, dan distribusi minyak esensial ke dalam sistem pernapasan terjadi melalui proses difusi.

Difusi alveolar tetap menjadi jalur potensial untuk pengiriman molekul volatil ke dalam sirkulasi sistemik yang memasuki otak. Molekul essential oil yang bersifat lipofilik dapat mengaktifkan daerah afinitas tertentu dalam sistem saraf pusat. Aktivasi ini menyebabkan efek psikologis dan fisiologis positif yang membantu meredakan gejala gangguan suasana hati. Sistem integumen juga diaktifkan oleh minyak esensial. Efek analgesik yang diperoleh saat menggunakan minyak esensial secara topikal, bersama dengan perasaan rileks, merupakan hasil dari pelepasan endorfin dan modulator nyeri tertentu yang cepat.

G. Manfaat *Frangipani Essential Oil* dalam Terapi Relaksasi

Frangipani essential oil dikenal karena efeknya yang menenangkan dan merelaksasi pikiran dan tubuh. Minyak ini dapat membantu mengurangi stress, kecemasan, dan meningkatkan suasana hati secara keseluruhan. Hal ini menjadikannya pilihan populer untuk digunakan dalam terapi pijat dan praktik meditasi.

Aroma *frangipani essential oil* yang menenangkan juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi gejala depresi. Hal ini menjadi pilihan alternatif cara alami untuk mengelola tingkat stres. Pemijatan dengan *frangipani essential oil* dapat membantu ibu bersalin merasa lebih nyaman dan mengurangi stres selama proses persalinan.



Gambar 5.9 Manfaat *frangipani essential oil*

Manfaat lain yang didapat dari penggunaan *frangipani essential oil* diantaranya adalah:

1. Melembabkan Kulit

Minyak yang didapatkan dari ekstrak kelopak bunga kamboja berperan sebagai zat yang bisa digunakan untuk melembabkan kulit, mencegah terjadinya kulit kering dan pecah-pecah. Penggunaan *frangipani essential oil* juga membantu membuat kulit terasa lebih halus dan lembut. Mengaplikasikan minyak frangipani bisa mencegah sejumlah penyakit kulit seperti eksim hingga psoriasis.

Kandungan glikosida pada kamboja membantu menyerap bahan-bahan penting lainnya ke dalam kulit untuk menghidrasi kulit dengan mengikat molekul air. Serta mendukung produksi kolagen yang sehat.

2. Melindungi Kulit dari Paparan Sinar Ultraviolet

Frangipani essential oil sangat ideal digunakan bagi seseorang yang aktif di luar ruangan. Minyak essensial ini memiliki kemampuan untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang mengandung sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan salah satu penyebab utama dampak negatif radikal bebas yang dapat mempercepat proses penuaan sel-sel kulit. Selain itu, paparan sinar UV yang berlebihan juga dapat menyebabkan hiperpigmentasi, yang membuat kulit tampak lebih gelap serta meningkatkan risiko kanker kulit.

3. Anti-aging

Seiring bertambahnya usia, kesehatan kulit seseorang mengalami perubahan, terutama dalam hal produksi produksi kolagen dan elastin. Kedua komponen ini sangat penting untuk menjaga kekencangan dan elastisitas kulit. Namun, seiring berjalannya waktu jumlah kolagen dan elastin yang diproduksi tubuh pasti mengalami

penurunan. Sehingga menyebabkan kulit menjadi lebih mudah kendur dan muncul garis-garis halus yang menandai keriput. Pemakaian minyak esensial frangipani membantu mengembalikan kekencangan kulit serta memudahkan kerutan secara alami.

Frangipani essential oil menjaga kulit tetap kenyal dan kencang berkat zat organik, Lignin. Minyak ini juga digunakan dalam produk anti-penuaan, antikerut, dan pengencangan kulit. Kerusakan jaringan yang disebabkan oleh stres oksidatif juga dapat dikurangi dengan penggunaan minyak esensial ini.

4. Meredakan Sakit Kepala

Minyak esensial frangipani memiliki sifat anti-inflamasi yang bermanfaat untuk meredakan sakit kepala, serta mengurangi rasa nyeri lainnya, seperti nyeri otot dan sakit punggung.

5. Sebagai Stimulan

Frangipani essential oil berfungsi sebagai stimulan yang mendukung kesehatan sistem peredaran darah, sistem saraf, dan berbagai fungsi tubuh lainnya.

6. Antioksidan

Kandungan antioksidan yang terdapat dalam *frangipani essential oil* berperan sebagai antioksidan dan anti-inflamasi yang mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Antioksidan ini bermanfaat untuk menghilangkan radikal bebas dari dalam tubuh. Serta mengurangi risiko terjangkit penyakit dengan menjaga tubuh tetap terlindungi dari serangan kuman.

BAB 6

PENUTUP

Buku monograf ini memiliki beberapa tujuan yang dirancang untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang kesehatan maternal, khususnya terkait pemberian terapi komplementer dalam penatalaksanaan nyeri persalinan.

Tujuan penulisan ini meliputi:

1. Memberikan Informasi Ilmiah
Menyajikan data dan kajian ilmiah mengenai efektivitas teknik deep back massage menggunakan minyak esensial frangipani dalam mengurangi nyeri persalinan pada kala 1 fase aktif.
2. Meningkatkan Pengetahuan Praktis
Membantu tenaga kesehatan, khususnya bidan, memahami dan mengimplementasikan metode ini sebagai intervensi non-farmakologis dalam manajemen nyeri persalinan.
3. Mendukung Praktik Kebidanan Berbasis Bukti
Mengintegrasikan pendekatan berbasis bukti (evidence-based practice) dalam pelayanan kebidanan, khususnya dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan persalinan.
4. Menyediakan Panduan Aplikatif
Memberikan panduan praktis mengenai prosedur, manfaat, dan langkah pelaksanaan teknik deep back massage dengan minyak esensial frangipani untuk mendukung tenaga kesehatan dalam penerapannya di lapangan.
5. Mengembangkan Alternatif Manajemen Nyeri

Menyediakan alternatif non-invasif yang aman, efektif, dan ramah bagi ibu hamil dalam menghadapi nyeri persalinan, sebagai pelengkap atau pengganti metode konvensional.

Buku ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi tenaga kesehatan, akademisi, dan mahasiswa dalam memahami dan mengadopsi intervensi inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. M. (2018). Original Article Effect of Change in Position and Back Massage on Pain Perception during First Stage of Labor. *Pain Management Nursing*, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2018.01.006>
- Allen, L. (2019) 'Therapeutic massage techniques', *Plain and Simple Guide to Therapeutic Massage & Bodywork Examinations*, p. 320.
- Ali B, Al-Wabel NA, Shams S, Ahamad A, Khan SA, Anwar F. Essential oils used in aromatherapy: a systemic review. *Asian PaK J Trop Biomed*. 2015;5(8):601–611
- Ali N, Ahmad D, Bakht J. Antimicrobial activity of different solvent extracted samples from the flowers of medicinally important *Plumeria obtusa*. *Pak J Pharm Sci*. 2015;28(1): 195–200.
- Armani, A. F., & Susanti, R. F. (2023). Ekstraksi Minyak Esensial Bunga Kamboja Putih (*Plumeria Obtusa*) dengan CO₂ Superkritik: Pengaruh Temperatur dan Tekanan. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 170–180. <https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2023.33.2.170>
- Ashagrie, H. E., Fentie, D. Y., & Kassahun, H. G. (2020). A review article on epidural analgesia for labor pain management: A systematic review. *International Journal of Surgery Open*, 24, 100–104.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijso.2020.04.007>

- Azizah, S. R., Qotrunnada, N., Suraya, S. V., Ferdiansyah, H. Y., & Pratiwi, E. D. (2022). *Kajian Pustaka Pemanfaatan Essential Oils Sebagai Aromaterapi dalam Perawatan Kulit*. 11(1), 62–77.
- Beyable, A. A., Bayable, S. D., Anesthesia, C., & Ashebir, Y. G. (2022). Pharmacologic and non-pharmacologic labor pain management techniques in a resource-limited setting: A systematic review. *Annals of Medicine and Surgery*, 74(January), 103312. <https://doi.org/10.1016/j.amsu.2022.103312>
- Breivik, H., Borchgrevink, P. C., Allen, S. M., Rosseland, L. A., Romundstad, L., Hals, E. K. B., Kvarstein, G., & Stubhaug, A. (2018). Assessment of pain. *British Journal of Anaesthesia*, 101(1), 17–24. <https://doi.org/10.1093/bja/aen103>
- Desmawati, Waraporn Kongsuwan, W. C. (2021). Level of Labor Pain, Level of Labor Pain Behaviors, and Cultural Pain Behaviors among First-Time Indonesian Muslim Mothers. *Open Journal of Obstetrics and Gynecology*, 11, 27–39. <https://doi.org/10.4236/ojog.2021.111004>
- Dubey S, Lata S. Self-comforting techniques and non-pharmacological methods to relieve pain during labor. *Int J Sci Res*. 2015;6(1):1594–1599
- El-Anssary, A. A. (2021). Aromatherapy as Complementary Medicine. In *IntechOpen*. www.intechopen.com
- Erdogan, S. U., Yanikkerem, E., & Goker, A. (2017). SC. Asuhan Kebidanan Persalinan: Intervensi Deep Back Massage Menggunakan Frangipani Essensial Oil Terhadap Penurunan Nyeri Persalinan Kala 1 Fase Aktif

Complementary Therapies in Clinical Practice.
<https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2017.05.016>

- Eskandari, F., Mousavi, P., Valiani, M., Ghanbari, S., & Iravani, M. (2022). A comparison of the effect of Swedish massage with and without chamomile oil on labor outcomes and maternal satisfaction of the childbirth process: a randomized controlled trial. *European Journal of Medical Research*, 1–10. <https://doi.org/10.1186/s40001-022-00901-x>
- Fatmawati, S., Astari, Z., & Bariroh, T. (2023). *Effect of Extraction Time And GC-MS Analysis of Fresh and Dry Frangipani Flower (Plumeria rubra L.) using Ultrasonic Assisted Extraction*. 11(1), 115–123.
- Fatmawati, S., Astari, Z., & Bariroh, T. (2023). *Effect of Extraction Time And GC-MS Analysis of Fresh and Dry Frangipani Flower (Plumeria rubra L.) using Ultrasonic Assisted Extraction*. 11(1), 115–123.
- Geltore, T. E., Hadaro, T. S., Oshine, W., Bekele, M., & Foto, L. L. (2024). Predictors of labor pain management among pregnant women in Ethiopia: A systematic review and meta-analysis. *Women's Health*, 1–10. <https://doi.org/10.1177/17455057241275442>
- Gholami-Motlagh, F., Jouzi, M., & Soleymani, B. (2016). Comparing the effects of two Swedish massage techniques on the vital signs and anxiety of healthy women. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 21(4), 402–409. <https://doi.org/10.4103/1735-9066.185584>

- Gosnell, E. S., & Thikkurissy, S. (2019). 7 - Assessment and Management of Pain in the Pediatric Patient. *Pediatric Dentistry*, 6(1), 97–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-323-60826-8.00007-9>
- Hariri, M. R., Irsyam, A. S. D., & Irwanto, R. R. (2019). *Plumeria pudica* Jacq.: TAMBAHAN UNTUK MARGA PLUMERIA (APOCYNACEAE) DI JAWA. *BIOTIKA Jurnal Ilmiah Biologi*, 17(2), 1. <https://doi.org/10.24198/biotika.v17i2.25454>
- Hariri, M. R., Irsyam, A. S. D., & Irwanto, R. R. (2019). *Plumeria pudica* Jacq.: TAMBAHAN UNTUK MARGA PLUMERIA (APOCYNACEAE) DI JAWA. *BIOTIKA Jurnal Ilmiah Biologi*, 17(2), 1. <https://doi.org/10.24198/biotika.v17i2.25454>
- Herman A, Herman AP. Essential oils and their constituents as skin penetration enhancer for transdermal drug delivery: a review. *J Pharm Pharmacol*. 2015;67(4):473–85.
- Idrees, S., Hanif, M. A., Ayub, M. A., Jilani, M. I., & Memon, N. (2019). Frangipani. In *Medicinal Plants of South Asia: Novel Sources for Drug Discovery* (pp. 287–300). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102659-5.00022-7>
- Javier, F., Peláez, R., & Taniguchi, S. (2016). The Gate Theory of Pain Revisited: Modeling Different Pain Conditions with a Parsimonious Neurocomputational Model. *Neural Plasticity*, 2016. <https://doi.org/10.1155/2016/4131395>

- Joel, A. A., Deborah, I. O., Falilat, O. A., Abiola, O. D., & Donald, B. (2015). Factors influencing perception of pain among clients attending a Nigeria teaching hospital. *International Journal of Nursing and Midwifery*, 7(8), 133–140. <https://doi.org/10.5897/ijnm2015.0174>
- Karcioglu, O., Topacoglu, H., Dikme, O., & Dikme, O. (2018). American Journal of Emergency Medicine A systematic review of the pain scales in adults: Which to use? *American Journal of Emergency Medicine*, 36(4), 707–714. <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2018.01.008>
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia 2017* (Vol. 1227, Issue July). <https://doi.org/10.1002/qj>
- Kim, J. I. (2018). Preterm labor and birth: Definition, assessment, and management. *Korean Journal of Women Health Nursing*, 24(3), 231–232. <https://doi.org/10.4069/kjwhn.2018.24.3.231>
- Maghalian, M., Mirghafourvand, M., Ghaderi, F., Abbasalizadeh, S., & Pak, S. (2022). stimulation on labor pain and childbirth experience in primiparous women: a Comparison the effect of Swedish massage and interferential electrical stimulation on labor pain and childbirth experience in primiparous women: a randomized controlled clinical trial. *Archives of Gynecology and Obstetrics*, July. <https://doi.org/10.1007/s00404-021-06220-6>
- Massoudifar, A., Alimi, N., Boostan, A., Etezadi, A., Haji, E., & Javadi, S. (2023). Investigating the Relationship Between the Perception of Labor Pain and the

Number of Deliveries. *Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research* |, 8(6), 549–555.
<https://doi.org/10.30699/jogcr.8.6.549>

Munevver, I., Fusun, G., & Lu, T. Ğ. (2020). *Effects of Massage and Acupressure on Relieving Labor Pain, Reducing Labor Time, and Increasing Delivery Satisfaction*. 28(1), 1–9.

Nori, W., Ali, M., Kassim, K., Helmi, Z. R., Pantazi, A. C., Brezeanu, D., Brezeanu, A. M., Penciu, R. C., & Serbanescu, L. (2023). Non-Pharmacological Pain Management in Labor: A Systematic Review. *Journal of Clinical Medicine Review*, 7203(12).
<https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jcm12237203>

Nugent, S. M., Lovejoy, T. I., Shull, S., Dobscha, S. K., & Morasco, B. J. (2021). Associations of Pain Numeric Rating Scale Scores Collected during Usual Care with Research Administered Patient Reported Pain Outcomes. *Pain Medicine*, 22(March), 2235–2241.
<https://doi.org/10.1093/pm/pnab110>

Puspitasari, E. (2020). HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI DAN KELUARGA DENGAN INTENSITAS NYERI PERSALINAN KALA I. *Jurnal Kesehatan*, 12(2), 118–124. <https://doi.org/10.23917/JK.V12I2.9768>

Shahbazzadegan, S., & Nikjou, R. (2022). The most appropriate cervical dilatation for massage to reduce labor pain and anxiety: a randomized clinical trial. *BMC Women's Health*, 1–8.
<https://doi.org/10.1186/s12905-022-01864-1>

- Sharareh, K. (2013). Outcomes assessment of pain relief techniques use in labour in order to increase painless normal delivery rate. *International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences*, 1(1), 1–4. <https://doi.org/10.15296/ijwhr.2013.01>
- Sheikh Faruque Elahee, Hui-juan Mao, Ling Zhao, X. S. (2020). Meridian system and mechanism of acupuncture action: A scientific evaluation. *World Journal of Acupuncture - Moxibustion*, 30(2), 130–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wjam.2020.05.003>
- Solehati, T. (2018). Terapi Nonfarmakologi Nyeri Padapersalinan: Systematic Review. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jkm.v3i1.1568>
- Sriasih, N. G. K., Hadi, M. C., Suindri, N. N., Surati, G. A., & Mahayati, N. M. D. (2019). The Effect of Massage Therapy Using Frangipani Aromatherapy Oil to Reduce the Childbirth Pain Intensity. *International Journal of Therapeutic Massage and Bodywork*, 12(2).
- Sriasih, N. G. K., Hadi, M. C., Suindri, N. N., Surati, G. A., & Mahayati, N. M. D. (2019). The effect of massage therapy using frangipani aromatherapy oil to reduce the childbirth pain intensity. *International Journal of Therapeutic Massage and Bodywork: Research, Education, and Practice*, 12(2), 18–24. <https://doi.org/10.3822/ijtmb.v12i2.404>
- Supliyani, E. (2017). Pengaruh Masase Punggung Terhadap Intensitas Nyeri Persalinan Kala 1 Di Kota Bogor.

- Tort, J., Rozenberg, P., Traoré, M., Fournier, P., & Dumont, A. (2015). Factors associated with postpartum hemorrhage maternal death in referral hospitals in Senegal and Mali: A cross-sectional epidemiological survey. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.1186/s12884-015-0669-y>
- Verma S. Multipurpose ornamental plant *Plumeria rubra* Linn (Apocynaceae). *IJSRSET*. 2016;2(4):646–649
- Vigil JM, Torres D, Wolff A, Hughes K. Exposure to virtual social stimuli modulates subjective pain reports. *Pain Res Manag*. 2014;19(4): e103–e108
- Vora, L. K., Gholap, A. D., Hatvate, N. T., Naren, P., Khan, S., Chavda, V. P., Balar, P. C., Gandhi, J., & Khatri, D. K. (2024). Essential oils for clinical aromatherapy: A comprehensive review. *Journal of Ethnopharmacology*, 330. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2024.118180>.
- Whitburn LY, Jones LE, Davey MA, McDonald S. Whitburn LY, Jones LE, Davey MA, M. S. (2019). The nature of labour pain: An updated review of the literature. *Women Birth*, 32(1), 28–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wombi.2018.03.004>
- Wolterskluwer (2018) 'Massage for the Stages of Labor', *Birth*, 1(1), pp. 152–180.
- World Health Organization (WHO). (2015). *Trends in maternal mortality 1990 to 2015. Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA and The World Bank*. 80.
- Asuhan Kebidanan Persalinan: Intervensi Deep Back Massage Menggunakan Frangipani Essensial Oil Terhadap Penurunan Nyeri Persalinan Kala 1 Fase Aktif

<http://datatopics.worldbank.org/hnp/files/Trends in Maternal Mortality 1990 to 2015 full report.PDF>

- Yuliani, Ni Gusti Ayu Mitha, Sriasih Ni Gusti Kompiang, N. G. K., & Budiani Ni Nyoman, N. N. (2020). Manfaat Aromaterapi Frangipani Sebagai Media Relaksasi Terhadap Intensitas Nyeri Post Sectio Caesarea Di Rumah Sakit Umum Premagana Gianyar Tahun 2020. Jurusan Kebidanan
- Yurtsev, E., & Şahin, N. (2021). Distraction and Focusing on the Management of Labour Pain: Stereograms. *Journal of Education and Research in Nursing*, 18(2), 196–201. <https://doi.org/10.5152/jern.2021.09069>

GLOSARIUM

A

Aromaterapi: adalah teknik pengobatan atau perawatan menggunakan wangi-wangian yang berasal dari minyak alami dari tumbuh-tumbuhan, bunga atau pohon yang berbau harum dan enak.

Anterior: istilah anatomi yang berarti tampak depan tubuh

D

Desidua: lapisan endometrium atau membrane mukosa Rahim yang terbentuk setiap bulan untuk mempersiapkan kehamilan

E

Enkephalin: sama dengan endorphen

F

Frangipani essential oil: adalah minyak essensial kamboja

Fundus: istilah yang menunjukan puncak dari uterus

H

Hormon endorphen: adalah zat kimia yang dihasilkan secara alami oleh kelenjar pituitari dan hipotalamus yang ada di dalam otak.

His: serangkaian kontraksi Rahim yang teratur yang mendorong janin melewati serviks dan vagina untuk keluar dari rahim

L

Ligamen: merupakan jaringan dengan bentuk seperti pita yang tersusun atas serabut-serabut yang berperan sebagai penghubung antara tulang pada sendi.

M

Minyak atsiri: adalah minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas.

Myometrium: lapisan tengah dan paling tebal dinding uterus yang terdiri dari serat otot polos

N

Neurogenesis: adalah proses produksi sel-sel sistem saraf.

Neurotransmitter: adalah senyawa kimia dalam tubuh yang berfungsi untuk membawa dan mengirimkan sinyal atau pesan antar neuron atau dari neuron ke berbagai jaringan tubuh.

P

Posterior: istilah anatomi yang berarti tampak belakang tubuh

V

Viable: mampu hidup atau layak untuk hidup

PROFIL PENULIS



Amrina Nur Rohmah, S.Tr.Keb., M.Keb.

Penulis lahir di Klaten pada 12 April 1994, adalah dosen tetap di Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Universitas Muhammadiyah Lamongan. Penulis menyelesaikan Diploma III Kebidanan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta (2014), Sarjana Terapan Kebidanan di Stikes Karya Husada Semarang (2017), dan Magister Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (2019) dengan predikat cum laude. Penulis aktif dalam Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat. Penulis mempublikasikan karya ilmiah di jurnal nasional dan internasional, serta menulis *BookChapter* tentang kehamilan, kontrasepsi, kesehatan reproduksi remaja, etika kebidanan, kebidanan komplementer, dan keterampilan klinis. Ia juga terlibat dalam pengabdian masyarakat di bidang kesehatan ibu, anak, dan remaja, serta berkontribusi sebagai koordinator International Summercourse Universitas Muhammadiyah Lamongan (2022), yang melibatkan peserta dari Malaysia, Mesir, dan Palestina.

Penulis dapat dihubungi melalui Email:

amrinanurrohmah12@gmail.com

PROFIL PENULIS



Dwi Dianita Irawan, S.Keb., Bd., M.Keb.

Lahir di Tuban, 12 Oktober 1992. Merupakan dosen tetap di Program Studi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Riwayat pendidikan Sarjana Kebidanan (2010) di Universitas Brawijaya Malang, Pendidikan Profesi Bidan (2015) di Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan studi S2 Kebidanan di Universitas Brawijaya Malang. Gelar Magister Kebidanan diperoleh pada tahun 2019. Aktif dalam penelitian, publikasi jurnal internasional dan nasional, serta aktif menulis buku. Penulis dapat dihubungi melalui email irawan.dianita36@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Risya Secha Primindari, S.Keb., Bd., M.Kes.

Lahir pada 27 Januari 1993 di Kota Jombang. Penulis adalah dosen tetap di Program Studi Profesi Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Menyelesaikan S1 Pendidikan Bidan pada tahun 2015 dan Profesi Bidan pada tahun

2016 di Universitas Airlangga. Gelar Magister Kesehatan pada Program Studi Ilmu Kesehatan Reproduksi Universitas Airlangga diperoleh penulis pada tahun 2020. Aktif dalam penelitian, publikasi jurnal internasional dan nasional, serta aktif menulis buku. Beberapa buku yang sudah diterbitkan berjudul Perkembangan Kontrasepsi Masa Kini yang diterbitkan pada tahun 2022, Kupas Tuntas Ginekologi dan Infertilitas diterbitkan pada tahun 2023, Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir tahun 2023, dan Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan dengan Pendekatan Komplementer tahun 2023. Penulis dapat dihubungi melalui email: risyasecha@gmail.com

PROFIL PENULIS



**Bdn. Shinta Alifiana Rahmawati, S.ST.,
M.Keb.**

Lahir di Rembang, 29 Juni 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma IV pada tahun 2016 di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan melanjutkan studi S2 Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Gelar Magister Kebidanan diperoleh pada tahun 2020 dengan mendapatkan predikat lulusan berprestasi terbaik program studi ilmu kebidanan program magister fakultas ilmu kesehatan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta tahun akademik 2019/2020. Dilanjutkan profesi bidan di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Lamongan sebagai dosen Program Studi S1 Bidan dan Pendidikan Profesi Bidan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saat ini menjabat sebagai UPM S1 Bidan dan menjadi auditee. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, aktif dalam penelitian, publikasi jurnal internasional dan nasional, serta aktif menulis buku. Penulis juga telah menghasilkan buku yang berjudul Menyusui dalam Kehamilan yang diterbitkan pada tahun 2021, Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir tahun 2023, Asuhan Kebidanan pada Kehamilan dengan Pendekatan Komplementer pada tahun 2024. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: shintaalifiana76@gmail.com

Motto: "LIVE YOUR LIFE TO THE FULLEST AND FOCUS"

SINOPSIS BUKU

Buku monograf berjudul **"Asuhan Kebidanan Persalinan: Intervensi Back Massage Menggunakan *Frangipani Essential Oil* Terhadap Penurunan Nyeri Persalinan Kala 1 Fase Aktif"** ini menyajikan panduan dan kajian mendalam mengenai upaya inovatif dalam manajemen nyeri persalinan melalui terapi non-farmakologis. Di era modern, semakin banyak ibu yang menginginkan pengalaman persalinan yang nyaman, minim intervensi medis, dan tetap aman. Buku ini hadir sebagai panduan praktis sekaligus referensi ilmiah bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam menerapkan teknik pijat punggung atau *back massage* menggunakan *Frangipani Essential Oil* untuk meredakan nyeri persalinan.

Melalui pendekatan berbasis bukti, buku ini menjelaskan secara terperinci tentang fase-fase persalinan dan tantangan nyeri pada fase aktif. Setiap bab dalam buku ini membahas berbagai aspek yang penting untuk dipahami, mulai dari anatomi punggung dalam massage, manfaat *Frangipani Essential Oil*, hingga teknik *back massage* yang tepat untuk ibu bersalin. Buku ini juga menguraikan metode aplikasi, langkah-langkah pijatan yang aman, serta potensi dampaknya bagi ibu dan bayi.

Sebagai hasil dari penelitian empiris, buku ini dilengkapi dengan hasil penelitian dan analisis efektivitas teknik ini dalam menurunkan nyeri kala 1 fase aktif. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan panduan praktis yang dapat langsung diterapkan, buku ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi baru dalam praktik kebidanan serta memberikan manfaat bagi ibu bersalin dalam menjalani proses persalinan yang lebih nyaman.

Buku monograf berjudul “Intervensi Back Massage Menggunakan Frangipani Essential Oil Terhadap Penurunan Nyeri Persalinan Kala 1 Fase Aktif” ini menyajikan panduan dan kajian mendalam mengenai upaya inovatif dalam manajemen nyeri persalinan melalui terapi non-farmakologis. Di era modern, semakin banyak ibu yang menginginkan pengalaman persalinan yang nyaman, minim intervensi medis, dan tetap aman. Buku ini hadir sebagai panduan praktis sekaligus referensi ilmiah bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam menerapkan teknik pijat punggung atau back massage menggunakan Frangipani Essential Oil untuk meredakan nyeri persalinan.

Melalui pendekatan berbasis bukti, buku ini menjelaskan secara terperinci tentang fase-fase persalinan dan tantangan nyeri pada fase aktif. Setiap bab dalam buku ini membahas berbagai aspek yang penting untuk dipahami, mulai dari anatomi punggung dalam massage, manfaat Frangipani Essential Oil, hingga teknik back massage yang tepat untuk ibu bersalin. Buku ini juga menguraikan metode aplikasi, langkah-langkah pijatan yang aman, serta potensi dampaknya bagi ibu dan bayi.

Sebagai hasil dari penelitian empiris, buku ini dilengkapi dengan hasil penelitian dan analisis efektivitas teknik ini dalam menurunkan nyeri kala 1 fase aktif. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan panduan praktis yang dapat langsung diterapkan, buku ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi baru dalam praktik kebidanan serta memberikan manfaat bagi ibu bersalin dalam menjalani proses persalinan yang lebih nyaman.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

